GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

SERIE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA N° 01-2026

Mayo

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADULTOS

Guía en Versión Resumida

CENTRO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Víctor Javier Suárez Moreno
Presidente Ejecutivo
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Gisely Hijar Guerra
Directora
CENTRO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD

Gisely Hijar Guerra
Subdirectora II
SUBDIRECCIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

Subdirección de Guías de Práctica Clínica
Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud
Instituto Nacional de Salud
Av. Defensores del Morro 2268 (Ex Huaylas) – Chorrillos
Lima 11, Perú
Telf. (511) 7481111 Anexo 1909

Esta Guía de Práctica Clínica se desarrolló en respuesta a un requerimiento de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas (DENOT) de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública (DGIESP) del Ministerio de Salud, como parte de la priorización de condiciones de salud para la elaboración de Guías de Práctica Clínica de alcance nacional (Resolución Ministerial N° 362-2024-MINSA).

El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Técnico Especializado del Ministerio de Salud del Perú dedicado a la investigación de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico. El Instituto Nacional de Salud tiene como mandato el proponer políticas y normas, promover, desarrollar y difundir la investigación científica- tecnológica y brindar servicios de salud en los campos de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición, producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, salud ocupacional, protección del medio ambiente y salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. A través de Centro de Evaluación de Tecnología en Salud (CETS), participa en el proceso de elaboración de documentos técnicos, basados en la mejor evidencia disponible, que sirvan como sustento para la aplicación de intervenciones en Salud Pública, la determinación de Políticas Públicas Sanitarias y la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

GRUPO ELABORADOR DE LA GUÍA

Expertos temáticos

Líder del grupo elaborador de la GPC

- Henry Alexander Anchante Hernández. Médico especialista en cardiología. Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima.

Expertos clínicos participantes en todas las etapas del desarrollo de la GPC

- Miguel Agustin Reyes Rocha. Médico especialista en cardiología. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Lima.
- José Hernán Valencia Rodríguez. Médico especialista en nefrología. Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima.
- Ursula Milagros Vargas Gómez. Médico especialista en cardiología. Hospital III Yanahuara, Arequipa.
- Lizbel Esteban Milla. Médico especialista en cardiología. Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lima.
- Victoria Celeste Armas Rodríguez. Médico especialista en cardiología. Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima.
- Jorge Luis Sotomayor Perales. Médico especialista en cardiología. Hospital III Juliaca Essalud, Puno.
- Germán Víctor Valenzuela Rodríguez. Médico especialista en cardiología y medicina interna. Clínica Delgado, Lima.
- Wilmer German Yabar Galindo. Médico especialista en cardiología. Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Lima.
- Roxana Mabel Chahuayo Sánchez. Enfermera. Dirección Regional de Salud de Junín, Junín.

Equipo metodológico

- Kevin Alexis Flores Lovon. Médico Cirujano. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Martha Bravo Vasquez. Médico Cirujano. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Miguel Angel Béjar Torres. Tecnólogo Médico. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Yurely Medalith Quispe Ruiz. Economista. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.

Revisores metodológicos

- Lesly Karem Chávez Rimache. Cirujana dentista. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Naysha Yamilet Becerra Chauca. Obstetra. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Jorge Giusepi Huaringa Marcelo. Médico especialista en medicina interna. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Coordinador Metodológico. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.

Equipo de gestión para el desarrollo de la GPC

- David Victorino Jumpa Armas. Médico especialista en gestión en salud. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Katherine Lizbeth López Huamán. Coordinadora de Gestión. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Raúl Alonso Timaná Ruiz. Médico especialista en gestión en salud. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.

EXPERTOS INVITADOS A VALIDACIÓN DE LA GPC

Ajuste Técnico de la GPC

Expertos clínicos invitados

- Marcos Lorenzo Pariona Javier. Médico especialista en cardiología. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Lima.
- Juan Enrique Valdiviezo Chunga. Médico especialista en cardiología. Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), Lima.
- Mariano Manuel Yáñez Cesti. Médico especialista en cardiología. Sociedad Peruana de Cardiología (SOPECARD).
- Deidryth Anita Bravo Soldevilla. Médico especialista en cardiología. Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima.
- Jhoseph Andersson Mijailov Huamán León. Médico especialista en cardiología. Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima.

Gestores invitados

- Carlos Enrique Diaz Arocutipa. Médico especialista en cardiología. Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas (DENOT). Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP), Ministerio de Salud.

Revisión Externa de la GPC

Revisor temático invitado

- Adrián V. Hernández Diaz, MD, PhD. Médico epidemiólogo clínico. Investigador del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. Profesor de Efectividad Comparativa e Investigación de Desenlaces, Escuela de Farmacia de la Universidad de Connecticut, EEUU.

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Todos los integrantes del grupo elaborador, así como las personas que participaron en la revisión de este documento, realizaron una declaración de intereses. Todos los participantes declararon no tener conflictos de interés en relación con los aspectos abordados en esta guía.

FINANCIAMIENTO

La presente Guía de Práctica Clínica fue financiada por el Instituto Nacional de Salud del Perú (INS). La institución no tuvo ningún papel en la selección de las preguntas de la guía ni en la formulación de las recomendaciones.

Repositorio de guías de práctica clínica:
https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/tipos/217-guias-de-practica-clinica



http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Los derechos reservados de este documento están protegidos por licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Esta licencia permite que la obra pueda ser libremente utilizada sólo para fines académicos y citando la fuente de procedencia. Su reproducción por o para organizaciones comerciales sólo puede realizarse con autorización escrita del Instituto Nacional de Salud, Perú.

Cita recomendada:
Instituto Nacional de Salud (Perú). Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en adultos. Versión Extensa. Lima: Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud, mayo del 2026. Serie Guías de Práctica Clínica N° 01-2026.

TABLA DE CONTENIDO

I. GENERALIDADES 9
I.1 Presentación del problema y fundamentos para la realización de la guía 9
I.2 Antecedentes 10
I.3 Conformación del grupo elaborador de la guía (GEG) 11
I.4 Siglas y acrónimos 11
II. MÉTODOS 11
II.1 Alcance y objetivo de la GPC 12
II.2 Ámbito asistencial de la GPC 12
II.3 Formulación de preguntas clínicas y preguntas PICO 12
II.4 Identificación de desenlaces 13
II.5 Búsqueda de evidencia 13
i. Búsqueda de GPC previas 13
ii. Búsqueda y selección de la evidencia para cada pregunta PICO 13
II.6 Evaluación y síntesis de la evidencia identificada 13
II.7 Graduación de la evidencia 14
II.8 Formulación de las recomendaciones, consideraciones adicionales y BPC 14
II.9 Revisión por expertos 15
III. RESUMEN DE LA GPC 15
III.1. Tabla 1. Lista completa de recomendaciones y buenas prácticas clínicas (BPC) 15
III.2. Interpretación de las recomendaciones 21
III.3. Flujogramas 23
IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES 27
IV.1 Pregunta 1. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar? 27
IV.2 Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica? 28
IV.3 Pregunta 3. En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar? 31
IV.4 Pregunta 4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia? 33
IV.5 Pregunta 5. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo en terapia combinada o monoterapia? 41
IV.6 Pregunta 6. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección? 41
IV.7 Pregunta 7. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser el objetivo de presión arterial? 47
IV.8 Pregunta 8. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial? 50
V. PLAN PARA LA ACTUALIZACION DE LA GPC 51
VI. PLAN PARA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GPC 51

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 52
VIII. GLOSARIO.....56

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADULTOS

GUÍA EN VERSIÓN RESUMIDA

I. GENERALIDADES

I.1 Presentación del problema y fundamentos para la realización de la guía

La hipertensión arterial es una elevación persistente de la presión sanguínea que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esta condición, cuando persiste a lo largo del tiempo, ocasiona daño orgánico y, en última instancia, conduce al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, renales, entre otras. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, además de contribuir de manera significativa a la carga global de enfermedad (1).

Considerando ello, se ha priorizado la elaboración de una guía de práctica clínica (GPC) para estandarizar y optimizar la prevención diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial en el Perú. Esta GPC tiene como objetivo mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes mediante recomendaciones basadas en evidencia científica actualizada.

Definiciones operativas

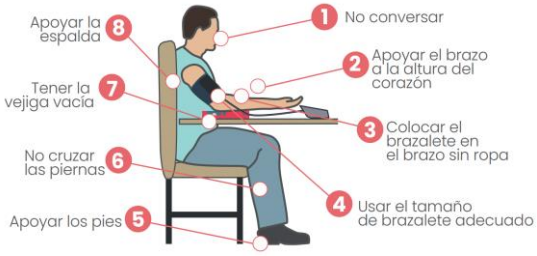
1. **Hipertensión arterial:** La hipertensión arterial se define como una PAS mayor a 140 mmHg y/o PAD mayor a 90 mmHg. Para confirmar el diagnóstico, repetir la medición de la presión arterial en una consulta posterior o realizar una Monitorización Ambulatoria de Presión Arterial (MAPA) (1).

2. Clasificación de hipertensión arterial

	Presión arterial en el consultorio (mmHg)	Presión arterial en casa (mmHg)	MAPA diurno (mmHg)	MAPA nocturno (mmHg)	MAPA de 24 horas (mmHg)
Presión arterial no elevada	<120/70	<120/70	<120/70	<110/60	<115/65
Presión arterial elevada	Entre 120/70 y <140/90	Entre 120/70 y <135/85	Entre 120/70 y <135/85	Entre 110/60 y <120/70	Entre 115/65 y <130/80
Hipertensión arterial	≥140/90	≥135/85	≥135/85	≥120/70	≥130/80

Adaptado y traducido: 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024 Oct 7;45(38):3912-4018.

3. Consideraciones para una medición precisa de la presión arterial en el consultorio

Instrucciones especificas	
1. Provea un ambiente tranquilo y templado.	
2. Explique al paciente el procedimiento a realizar.	
3. Compruebe que el paciente no haya fumado ni ingerido café o alcohol, o haya realizado ejercicio físico en los últimos 30 minutos antes de la medición.	
4. El paciente debe encontrarse al menos 5 minutos en reposo.	
5. Utilizar tensiómetros automáticos clínicamente validados (https://www.validatebp.org/, https://www.stridebp.org/).	
6. Se deben cumplir con las siguientes condiciones durante la medición de la presión arterial: • No conversar • Apoyar el brazo a la altura del corazón • Colocar el manguito en el brazo sin ropa • Usar el tamaño de manguito adecuado • Apoyar los pies • No cruzar las piernas • Tener la vejiga vacía • Apoyar la espalda	
7. En la primera consulta, tomar las mediciones de la presión arterial en ambos brazos y usar el brazo con la medición más alta para mediciones posteriores.	
8. En cada consulta, tomar al menos dos mediciones de la presión arterial luego de un intervalo de 30 segundos y calcular el promedio.	

Adaptado y traducido: Jones DW, et al. 2025 AHA /ACC /AANP /AAPA /ABC /ACCP /ACPM /AGS /AMA /ASPC /NMA /PCNA /SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Hypertension. 2025.

I.2 Antecedentes

La hipertensión pertenece a las enfermedades crónicas con mayor carga de morbilidad y mortalidad. A nivel mundial, se estima que la prevalencia de hipertensión arterial alcanza el 31,1%, con una tendencia al alza especialmente en países de ingresos bajos y medianos (2). De forma similar, en Latinoamérica y el Caribe, la prevalencia en adultos que viven en zonas de altura es de 19,1% (3). En Perú, la prevalencia reportada es de 22%, con una incidencia aproximada de 4 casos nuevos por cada 100 personas año (4). No obstante, a pesar de los esfuerzos de control, únicamente entre el 18% y 23% de los pacientes hipertensos alcanzan niveles adecuados de presión arterial (5).

I.3 Conformación del grupo elaborador de la guía (GEG)

Se conformó un GEG, que incluyó profesionales de salud, especialistas en gestión en salud y con experiencia en el desarrollo de guías de práctica clínica.

I.4 Siglas y acrónimos

ACV:	Accidente cerebrovascular
AGREE II:	*Appraisal of Guidelines Research and Evaluation II*
BB:	Betabloqueantes
BCC:	Bloqueadores de los Canales de Calcio
BPC:	Buenas Prácticas Clínicas
DENOT:	Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas
DR:	Diferencia de riesgos
ECA:	Ensayo controlado aleatorizado
EO:	Estudio Observacional
EsSalud:	Seguro Social de Salud
EtD:	Marco de la evidencia para la recomendación (del inglés "*Evidence to decisión/recommendation")*
ETS:	Evaluación de tecnología en Salud
GEG:	Grupo Elaborador de la Guía
GPC:	Guías de Práctica Clínica
GRADE:	*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*
HTA:	Hipertensión Arterial
HR:	Hazard Ratio
IC:	Intervalo de Confianza
IECA:	Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina
IETSI:	Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación
IMA:	Infarto Agudo al Miocardio
INS:	Instituto Nacional de Salud
MAPA:	Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial
NI:	No Información
NICE:	*National Institute for Health and Care Excellence*
OR:	Odds Ratio
PAS:	Presión arterial Sistólica
PAD:	Presión arterial Diastólica
PICO:	Población, Intervención, Comparador, Desenlaces (del inglés *"Population, Intervention, Comparator, Outcome")*
RIS:	Redes Integradas de Salud
RR:	Riesgo Relativo
RS:	Revisiones Sistemáticas
SoF:	Summary of Findings
SOPECARD:	Sociedad Peruana de Cardiología
TFG:	Tasa de Filtración Glomerular
UIT:	Unidad Impositiva Tributaria

II. MÉTODOS

El procedimiento seguido para la elaboración de la presente GPC está detallado en su versión extensa, la cual puede descargarse del repositorio de guías de práctica clínica del Instituto Nacional de Salud del Perú (https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/tipos/217-guias-de-practica-clinica). En resumen, se aplicó la siguiente metodología:

II.1 Alcance y objetivo de la GPC

Objetivo

Brindar a los profesionales de salud recomendaciones informadas en evidencia para la toma de decisiones respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial.

Población objetivo

Adultos de 18 años o más, con o sin diagnóstico previo de hipertensión arterial, que incluyen a quienes presentan comorbilidades de alto riesgo como diabetes, enfermedad renal crónica o antecedente de enfermedad cardiovascular, y que reciben atención en los establecimientos de salud.

II.2 Ámbito asistencial de la GPC

Usuarios de la GPC

La guía está dirigida a todo el personal de salud que tenga a su cargo la prevención, diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial como médicos generales, médicos de familia, internistas, cardiólogos, enfermeras u otro profesional de la salud que brinda atención a estos pacientes, así como gestores responsables de tomar decisiones a nivel institucional, regional o nacional, con el fin de facilitar el proceso de implementación.

Ámbito de aplicación

La presente GPC tiene como ámbito de aplicación los establecimientos de salud de las Redes Integradas de Salud (RIS), de las Direcciones Regionales de Salud, de las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional, que realicen prevención, diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial. Así mismo, servirá como referente para los demás establecimientos de salud del Seguro Social de Salud (EsSalud), de las Instituciones Armadas, de la Policía Nacional del Perú, así como para los establecimientos de salud privados y otros prestadores que brinden atenciones de salud en todo el país.

Aspectos no cubiertos

La presente guía no cubre el manejo en menores de 18 años, hipertensión secundaria, hipertensión gestacional e hipertensos con insuficiencia cardiaca.

Procedimiento a estandarizar

Nombre: Prevención, diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial.

Código CIE-10: I10

II.3 Formulación de preguntas clínicas y preguntas PICO

En concordancia con los objetivos y alcances de esta GPC, el GEG formuló preguntas clínicas **(Tabla 1)**, cada una de las cuales pudo tener una o más preguntas PICO (Population, Intervention, Comparator, Outcome). A su vez, cada pregunta PICO pudo tener uno o más desenlaces (o outcomes) de interés.

II.4 Identificación de desenlaces

El GEG, en base a la revisión de la literatura y su experiencia, elaboró una lista de desenlaces (*outcomes*) por cada pregunta PICO, los cuales fueron calificados por el GEG usando un puntaje de 1 a 9, para poder categorizarlos en: desenlaces poco importantes (con puntaje promedio menor a 4), desenlaces importantes (con puntaje promedio mayor o igual a 4, pero menor a 7), y desenlaces críticos (con puntaje promedio de 7 o más). Los desenlaces para cada pregunta se presentan en la descripción de las preguntas PICO de cada pregunta clínica.

Para la toma de decisiones en el proceso de elaboración de esta GPC, se seleccionaron los desenlaces importantes y críticos.

II.5 Búsqueda de evidencia

i. Búsqueda de GPC previas

Se identificaron 2 GPC que cumplieron con los criterios previamente señalados, por lo que fueron evaluadas por dos metodólogos de forma independiente, empleando el instrumento *Appraisal of Guidelines Research and Evaluation II (AGREE II)* (6) a fin de seleccionar aquellas GPC que fueran de buena calidad metodológica, es decir, que alcanzaran un puntaje mayor de 90% en la evaluación global y mayor del 60% en cada uno de los siguientes dominios: Alcance y objetivo (Dominio 1), Rigor en la elaboración (Dominio 3) y aplicabilidad (Dominio 5). En base a esta evaluación, se identificaron 2 GPC:

- World Health Organization. Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults. Genova. 2021 (7).
- Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial (HTA). 2024 (8).

ii. Búsqueda y selección de la evidencia para cada pregunta PICO

Para cada pregunta PICO, durante el 2025, se buscaron revisiones sistemáticas (RS) publicadas como artículos científicos (mediante búsquedas sistemáticas en PubMed, LILACS y CENTRAL) o realizadas como parte de una GPC previa (mediante una búsqueda sistemática de GPC). Cuando se encontraron RS de calidad aceptable según el instrumento *A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews-II (AMSTAR II)* (9), se escogió una para cada desenlace de interés, la cual fue actualizada cuando el GEG lo consideró necesario. Cuando no se encontró ninguna RS de calidad aceptable, se realizó una búsqueda de *novo* de ECA y estudios primarios.

II.6 Evaluación y síntesis de la evidencia identificada

La evaluación del riesgo de sesgo se realizó principalmente en los casos en que la revisión sistemática seleccionada no había evaluado los estudios incluidos o cuando la evaluación realizada carecía de calidad suficiente. También se efectuó cuando la evaluación cubría múltiples desenlaces y se anticipaba que los resultados podrían variar al centrarse en el desenlace específico de interés. Para esta evaluación, se emplearon las siguientes herramientas: la herramienta de riesgo de sesgo de Cochrane para ensayos clínicos aleatorizados (ECA) (10) y la herramienta de *Newcastle-Ottawa* para estudios observacionales (11).

Para cada desenlace relacionado con las preguntas PICO, la certeza de la evidencia se evaluó siguiendo la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation* (GRADE) (12). Además, se calcularon los efectos absolutos

para cada desenlace, utilizando diferencias de riesgos para desenlaces dicotómicos y diferencias de medias para desenlaces numéricos. En el cálculo de las diferencias de riesgos, se utilizó la incidencia del desenlace en el grupo control tal como fue reportada en el conjunto de evidencia, salvo indicación contraria para alguna pregunta específica.

II.7 Graduación de la evidencia

La calificación del cuerpo de la evidencia se realizó utilizando del sistema GRADE.

Significado de los niveles de certeza de la evidencia.

Enunciado	Significado
Certeza del resultado de un desenlace	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Estamos muy seguros de que el efecto real de la intervención se aproxima al efecto estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***estamos seguros que*** …"
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Confiamos moderadamente en la estimación del efecto: lo más probable es que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es posible que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***probablemente*** …"
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: es posible que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es probable que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***podría ser que*** …"
Muy baja (⊕◯◯◯)	Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: lo más probable es que el verdadero efecto sea sustancialmente diferente del estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***la evidencia es muy incierta sobre*** …"
Certeza de una recomendación	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es alta.
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es moderada.
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es baja.
Muy baja (⊕◯◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es muy baja.

II.8 Formulación de las recomendaciones, consideraciones adicionales y BPC

El GEG revisó la evidencia seleccionada para cada pregunta clínica en reuniones periódicas, usando los marcos *Evidence to Decision* (EtD) de la metodología GRADE (13). Para ello, tuvo en consideración: 1) Beneficios y daños de las opciones, 2) Valores y preferencias de los pacientes, 3) Aceptabilidad por parte de los profesionales de salud y pacientes, 4) Equidad, 5) Factibilidad de las opciones, y 6) Uso de recursos. Luego de discutir estos criterios para cada pregunta, el GEG, por consenso o por mayoría simple, formuló cada recomendación, asignándole una fuerza (fuerte o condicional) y una certeza de la evidencia (alta, moderada, baja, o muy baja) (14).

Finalmente, de creerlo necesario, se emitirán consideraciones y/o BPC, para las cuales no se efectúa una evaluación de la certeza de la evidencia ni se aplica el marco EtD. Estas pautas deben distinguirse claramente de las recomendaciones. Las consideraciones son enunciados que apoyan la interpretación de las recomendaciones y pueden abarcar los subdominios de la estructura PICO (paciente/población, intervenciones, comparadores, desenlaces), así como las condiciones que enmarcan una o más recomendaciones específicas. Estos enunciados se justifican citando la evidencia correspondiente, como otras GPC, ensayos clínicos, entre otros.

De manera similar, las BPC deben estar debidamente justificadas en base a los siguientes criterios para ser considerados como tal (15,16):

- No pueden ser incluidas en la GPC como preguntas clínicas, debido a que luego de realizar una búsqueda preliminar (al menos de RS y ECA) no se encontró evidencia directa o la evidencia directa es muy difícil de encontrar y no es concluyente (lo cual debe argumentarse comentando la evidencia indirecta o directa de haberla).
- Es una pauta accionable (debe orientar una decisión).
- Es una pauta relevante y necesaria para la práctica clínica actual (para ello, se pueden citar otras guías o protocolos que consensuen que esta es una práctica usual).
- Existen razones claras para pensar que su implementación resulta en un gran beneficio para el paciente (lo cual se debe argumentar claramente).

Además, se diseñaron los flujogramas que resumen las principales recomendaciones de la GPC.

II.9 Revisión por expertos

La presente GPC fue revisada en reuniones con especialistas representantes de otras instituciones, y tomadores de decisiones del MINSA. Asimismo, su versión extensa fue enviada por vía electrónica a expertos externos para su revisión. Cuando fue pertinente, el GEG tuvo en cuenta los resultados de estas revisiones para modificar las recomendaciones finales.

III. RESUMEN DE LA GPC

III.1. Tabla 1. Lista completa de recomendaciones y buenas prácticas clínicas (BPC)

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
Pregunta 1. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?		
En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, se recomienda realizar actividad física al menos 150 minutos semanales.	Recomendación fuerte a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, se recomienda reducir el consumo de sal a menos de 5 gramos por día, que equivale a menos de 2 gramos de sodio por día en la dieta.	Recomendación fuerte a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, considerar realizar actividad física de intensidad moderada (caminar, trotar, andar en bicicleta o nadar) en sesiones no menores a 30 minutos de 5 a 7 días por semana. Como alternativa, puede efectuarse actividad física de intensidad vigorosa por un total de 75 minutos semanales, distribuidos en tres sesiones por semana.	BPC	No aplica
En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial, considerar brindar consejería para la adopción de estilos de vida saludable:	BPC	No aplica

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
• Evitar el consumo de alcohol • Cese del tabaquismo • Mantener un peso adecuado. • Mantener una alimentación saludable • Reducción del estrés		
Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica?		
Adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo¥		
En adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo¥ con presión arterial sistólica basal mayor o igual a 140 mmHg, se recomienda iniciar terapia antihipertensiva. **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo¥ considerar para el inicio de terapia antihipertensiva una presión diastólica mayor o igual a 90 mmHg.	Recomendación fuerte a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2		
En adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2 y presión arterial sistólica basal mayor o igual a 130 mmHg, se sugiere iniciar terapia antihipertensiva. **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2 considerar para el inicio de terapia antihipertensiva una presión diastólica mayor o igual a 80 mmHg.	Recomendación condicional a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica		
En adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica con presión arterial sistólica basal mayor o igual a 130 o presión diastólica basal mayor o igual a 80 mmHg, considerar iniciar terapia antihipertensiva	BPC	No aplica
Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular*		
En adultos de 18 años a más con antecedente de enfermedad cardiovascular* y presión arterial sistólica basal mayor o igual 130 mmHg se recomienda iniciar terapia antihipertensiva. **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular*, considerar para el inicio de terapia antihipertensiva una presión diastólica mayor o igual a 80 mmHg.	Recomendación fuerte a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, considerar realizar análisis auxiliares que incluya, hemograma, creatinina sérica, perfil lipídico, glucosa sérica, examen completo de orina, electrolitos séricos, albuminuria (cociente albumina/creatinina en orina), electrocardiograma de 12 derivadas con el objetivo de	BPC	No aplica

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
identificar el daño a órgano blanco y optimizar el tratamiento.		
Pregunta 3. En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?		
En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, se recomienda realizar actividad física al menos 150 minutos semanales.	Recomendación fuerte a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, se recomienda reducir el consumo de sal a menos de 5 gramos por día, que equivale a menos de 2 gramos de sodio por día en la dieta	Recomendación fuerte a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, considerar realizar actividad física cardiovascular de intensidad moderada (caminar, trotar, andar en bicicleta o nadar) en sesiones no menores a 30 minutos de 5 a 7 días por semana. Como alternativa, puede efectuarse actividad física de intensidad vigorosa por un total de 75 minutos semanales, distribuidos en tres sesiones por semana según la condición clínica individual.	BPC	No aplica
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, considerar brindar consejería para la adopción de estilos de vida saludable: • Evitar el consumo de alcohol • Cese del tabaquismo • Mantener un peso adecuado • Adoptar un plan de alimentación para pacientes con hipertensión arterial. • Reducción del estrés	BPC	No aplica
En adultos con hipertensión arterial, considerar el uso de la calculadora de riesgo HEARTS para la estimación del riesgo cardiovascular global.	BPC	No aplica
Pregunta 4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?		
Adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo¥		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo¥ que tienen indicaciones de monoterapia antihipertensiva, se recomienda brindar alguna de las siguientes alternativas: • IECA: Baja (⊕⊕◯◯) • ARA II: Muy baja (⊕◯◯◯) • BCC: Moderado (⊕⊕⊕◯) • Diuréticos tiazídicos: Baja (⊕⊕◯◯) **<u>Consideraciones adicionales</u>**	Recomendación fuerte a favor	La certeza acompaña a cada intervención

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
En caso de presentar eventos adversos no tolerables, considerar utilizar otro fármaco antihipertensivo de la lista.		
Adultos de 80 años o más		
En adultos de 80 años o más con hipertensión arterial que tienen indicación de monoterapia antihipertensiva, se sugiere brindar: • IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos **Consideraciones adicionales:** Considerar la individualización del tratamiento según las comorbilidades, la fragilidad y la tolerancia del adulto mayor.	Recomendación condicional a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
Adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que tienen indicación de monoterapia antihipertensiva, se sugiere brindar: • IECA: Baja (⊕⊕◯◯) **Consideraciones adicionales:** En caso de iniciar un IECA y presentar eventos adversos no tolerables, considerar utilizar un ARA II.	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica estadio I al III† con albuminuria grado A1-A3‡ que tienen indicaciones de monoterapia antihipertensiva, se recomienda brindar: • IECA: Moderada (⊕⊕⊕◯) • ARA II: Baja (⊕⊕◯◯) **Consideraciones adicionales:** En estadio IV y V, considerar individualizar el tratamiento de acuerdo a criterio clínico.	Recomendación fuerte a favor	La certeza acompaña a cada intervención
Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular*		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular que tienen indicación de monoterapia antihipertensiva, se sugiere brindar: • IECA: Baja (⊕⊕◯◯)	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Pregunta 5. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo en terapia combinada o monoterapia?		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial considerar brindar terapia combinada con dos antihipertensivos a dosis baja como tratamiento de inicio.	BPC	No aplica
Pregunta 6. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?		
Adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo¥		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo¥ que tienen indicación de terapia combinada a dosis bajas, se sugiere brindar: • IECA/ARA II + BCC: Baja (⊕⊕◯◯)	Recomendación condicional a favor	La certeza acompaña a cada intervención

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
• IECA/ARA II + diuréticos tiazídicos: Baja (⊕⊕◯◯) **Consideraciones adicionales:** En caso de presentar eventos adversos no tolerables, considerar el uso de otro esquema antihipertensivo de la lista.		
Adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que tienen indicación de terapia combinada a dosis bajas, se sugiere brindar: • IECA/ARA II + BCC: Baja (⊕⊕◯◯) • IECA/ARA II + diuréticos tiazídicos: Muy baja (⊕◯◯◯) **Consideraciones adicionales:** En caso de presentar eventos adversos no tolerables, considerar el uso de otro esquema antihipertensivo de la lista.	Recomendación condicional a favor	La certeza acompaña a cada intervención
Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica estadio I al III † con albuminuria grado A1-A3‡, considerar como tratamiento inicial terapia combinada a dosis bajas de: • IECA o ARA II en combinación con BCC o diuréticos tiazídicos. **Consideraciones adicionales:** En estadio IV y V, considerar individualizar el tratamiento de acuerdo a criterio clínico.	BPC	No aplica
Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular*		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cerebrovascular que tienen indicación de terapia combinada a dosis bajas, se sugiere brindar: • IECA/ARA II + diuréticos tiazídicos: Muy baja (⊕◯◯◯) **Consideraciones adicionales:** Considerar como alternativa: IECA/ARA II + BCC.	Recomendación condicional al favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad coronaria considerar brindar terapia combinada con IECA/ARA II + BB	BPC	No aplica
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad arterial periférica considerar brindar terapia combinada con IECA/ARA II + BCC	BPC	No aplica
Pregunta 7. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?		
Adultos de 18 años sin comorbilidades de alto riesgo¥		

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo¥, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg. **Consideraciones adicionales:** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo¥, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 80 mmHg.	Recomendación condicional al favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Adultos de 65 años o más		
En adultos de 65 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 140 mmHg. **Consideraciones adicionales:** En adultos de 65 años o más con hipertensión arterial, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 90 mmHg.	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
En adultos de 80 años o más con hipertensión arterial, considerar una meta de presión arterial entre 140 a 150 mmHg de manera individualizada y según criterio clínico.	BPC	No aplica
Adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg **Consideraciones adicionales:** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 80 mmHg.	Recomendación condicional a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg. **Consideraciones adicionales:** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 80mmHg.	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular*		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular*, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg. **Consideraciones adicionales:** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 80 mmHg.	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Pregunta 8. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que alcancen meta terapéutica, se sugiere realizar la reevaluación de la presión arterial cada 3 meses.	Recomendación condicional a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
Consideraciones adicionales: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que presenten signos clínicos de presión arterial no controlada, considerar realizar la reevaluación de la presión arterial según criterio clínico.		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo, se sugiere realizar la reevaluación de la presión arterial en un periodo de tiempo no mayor a 30 días, hasta que alcancen la meta terapéutica.	Recomendación condicional a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)

* Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica.
¥ Las comorbilidades de alto riesgo incluyen diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o antecedente de enfermedad cardiovascular.
† Tasa de filtración glomerular estimada: Grado 1 ≥ 90 mL/min/1.73 m2, Grado 2 entre 60 a 89 mL/min/1.73 m2, Grado 3a entre 45 a 59 mL/min/1.73 m2, Grado 3b entre 30 a 44 mL/min/1.73 m2, Grado 4 entre 15 a 29 mL/min/1.73 m2 y Grado 5 < 15 mL/min/1.73 m2.
‡ Albuminuria: Grado A1: Normal o levemente incrementada <30 mg/g, Grado A2: moderadamente incrementada entre 30 a 299 mg/g y A3: severamente incrementada > a 300 mg/g.

III.2. Interpretación de las recomendaciones

¿Como interpretar la fuerza y dirección de una recomendación?

Fuerza y dirección de la recomendación	Significado
Recomendación fuerte (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación debe aplicarse en todos o casi todos los casos, excepto en situaciones puntuales y justificadas. Por lo general, este tipo de recomendación se emite cuando los beneficios de una intervención superan ampliamente a los daños. Se usó el término "**Recomendamos**"
Recomendación condicional (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación es adecuada en la mayoría de los casos, pero implica que la decisión debe ser individualizada. Por lo general, esto puede depender de factores como el contexto clínico, las preferencias del paciente, la disponibilidad de recursos, entre otros criterios relevantes. Se usó el término "**Sugerimos**"

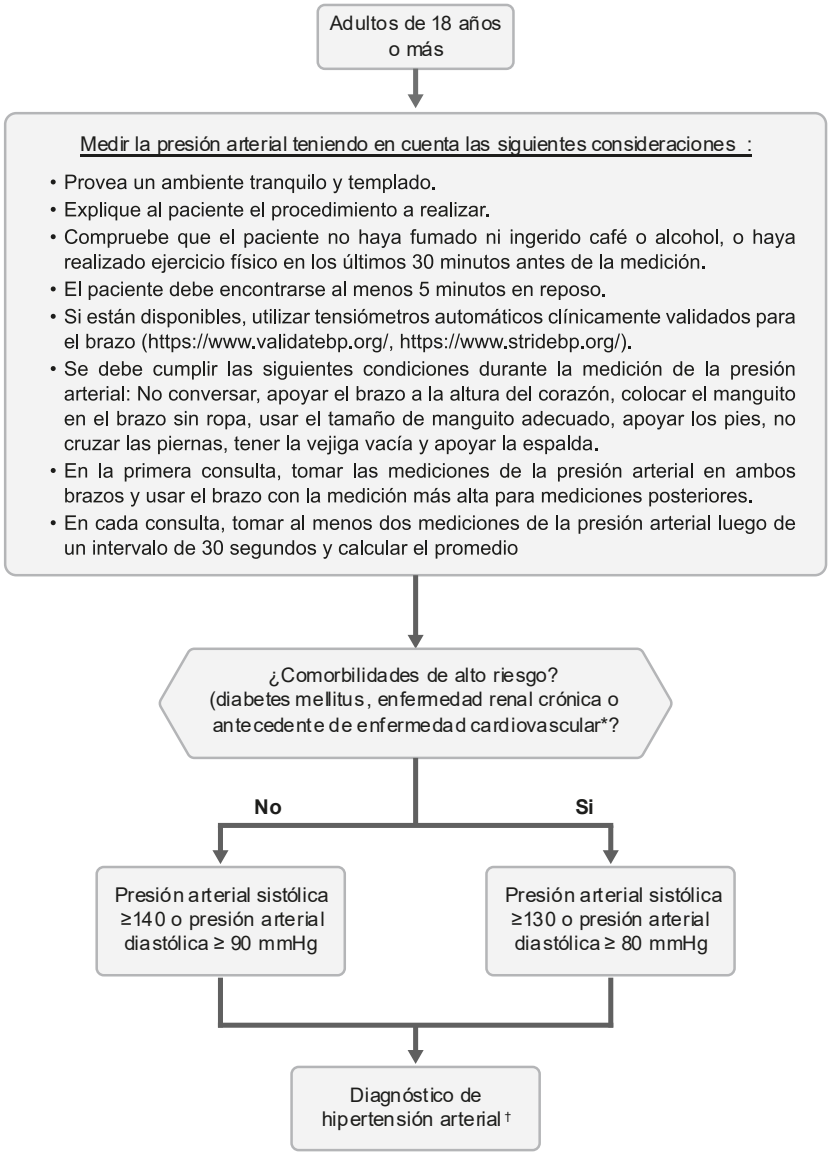
¿Como interpretar la certeza de la evidencia de una recomendación?

Enunciado	Significado
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es alta.
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es moderada.

Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es baja.
Muy baja (⊕◯◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es muy baja.

III.3. Flujogramas

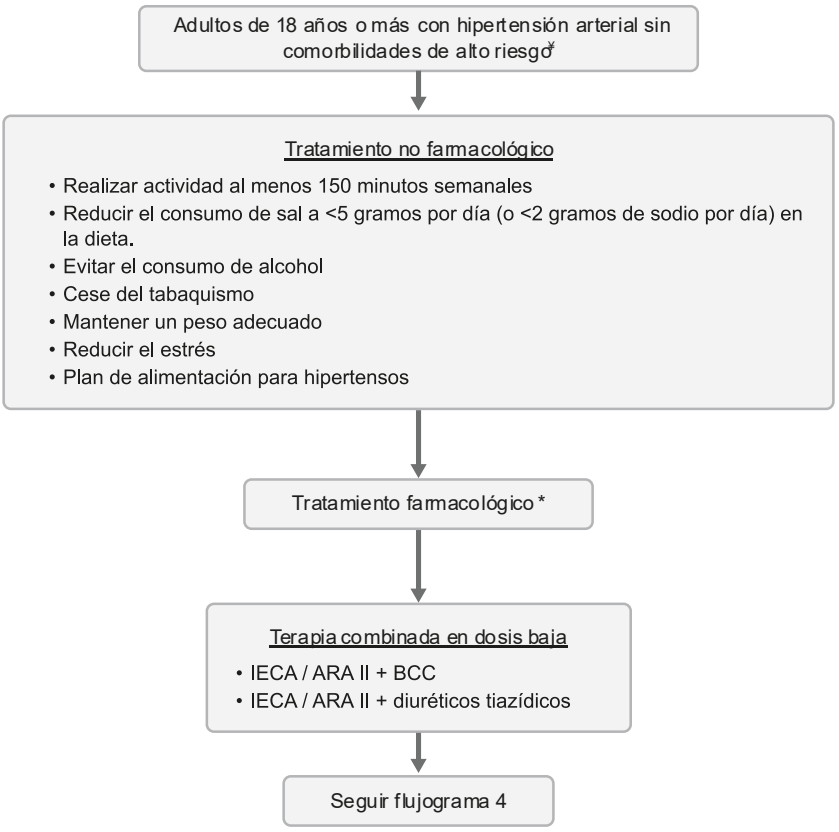
Flujograma 1: Diagnóstico de hipertensión arterial en adultos de 18 años o más



* Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica arterial periférica

† La confirmación del diagnóstico debe basarse en mediciones obtenidas en, al menos, dos visitas al establecimiento de salud en días distintos. Cuando esté disponible, se puede confirmar el diagnostico mediante Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA) o Monitoreo Domiciliario de la Presión Arterial (MDPA), según criterio médico.

Flujograma 2: Tratamiento de adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo ¥



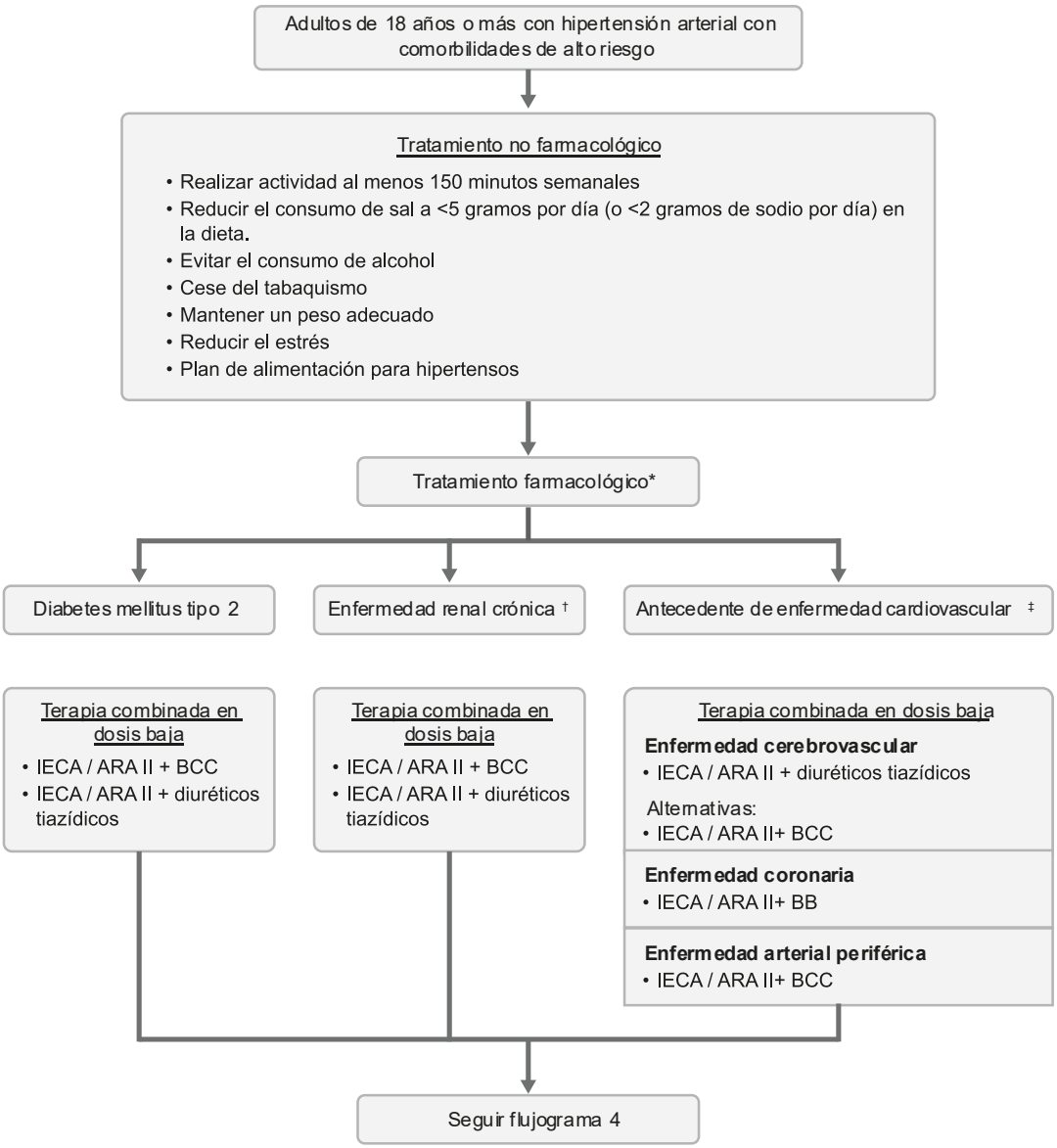
* Considerar monoterapia en los siguientes casos (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos)
- Fragilidad moderada a severa†
- Hipotensión ortostática sintomática
- Edad ≥ 80 años

Abreviaturas: IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, **ARA II**: Antagonista de los receptores de angiotensina II , BCC: Bloqueadores de canales de calcio dihidropiridinicos .

† Puntaje en la Escala Clínica de Fragilidad entre6 y 7

¥ Las comorbilidades de alto riesgo incluyen diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o antecedente de enfermedad cardiovascular

Flujograma 3: Tratamiento de adultos de 18 años a más con hipertensión arterial con comorbilidades de alto riesgo



Abreviaturas: IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, **ARA II:** Antagonista de los receptores de angiotensina II, **BCC:** Bloqueadores de los canales de calcio

* Considerar monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos) en los siguientes casos: Fragilidad moderada a severa (Puntaje en la Escala Clínica de Fragilidad entre 6 y 7), hipotensión ortostática sintomática y edad ≥80 años.

† Grado 1 al 3 con albuminuria >30 mg/g.

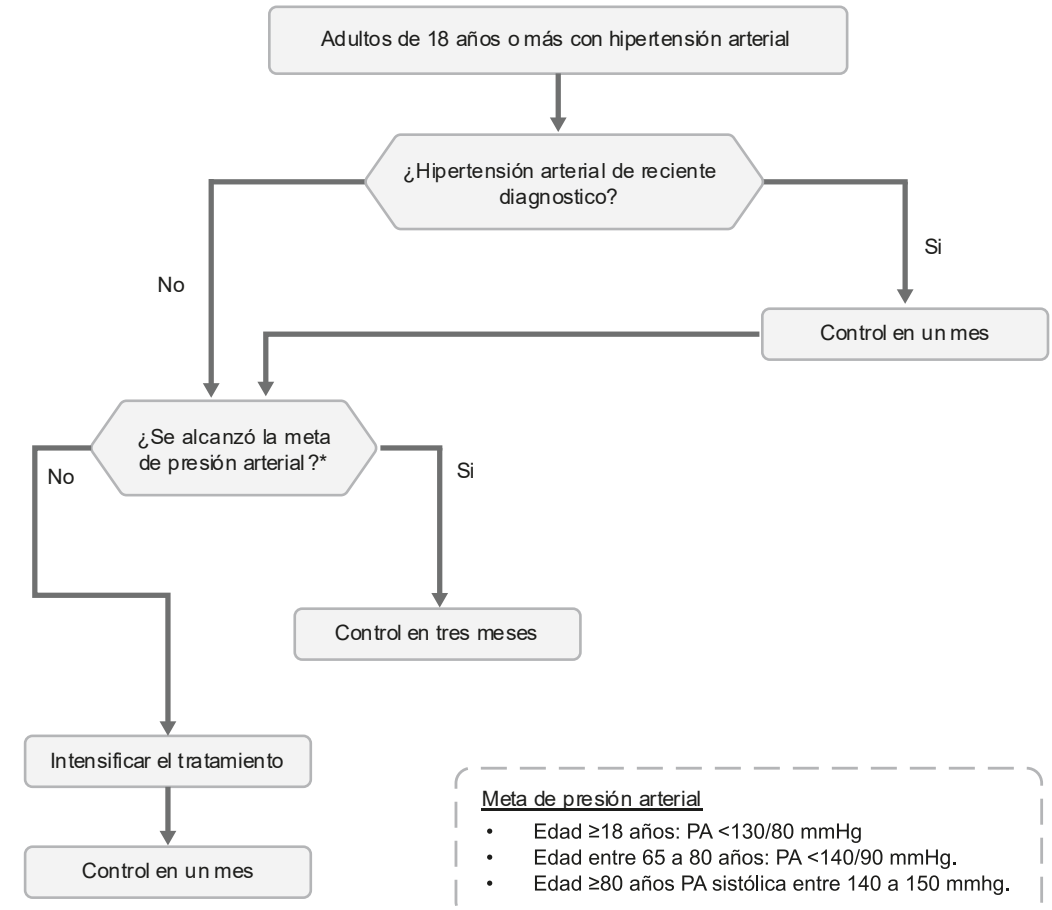
‡ Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica

Clasificación de tasa de filtración glomerular y albuminuria según KDIGO2024:

Tasa de filtración glomerular estimada: Grado 1 ≥ 90 mL/min/1.73 m2, Grado 2 entre 60 a 89 mL/min/1.73 m2, Grado 3a entre 45 a 59 mL/min/1.73 m2, Grado 3b entre 30 a 44 mL/min/1.73 m2, Grado 4 entre 15 a 29 mL/min/1.73 m2 y Grado 5 < 15 mL/min/1.73 m2.

Albuminuria: Grado A1: Normal o levemente incrementada<30 mg/g, Grado A2: moderadamente incrementada entre 30 a 299 mg/g y A3: severamente incrementada > a 300 mg/g.

Flujograma 4: Reevaluación en consultorio de adultos de 18 años o más con hipertensión arterial



Abreviaciones: PA: Presión arterial.

IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES

IV.1 Pregunta 1. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

Evidencia: Se consideró la búsqueda realizada por la GPC de Argentina "Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial (HTA)" (17). Esta GPC realizó la búsqueda de revisiones sistemáticas con periodo de 2015 a 2019 en Medline/Pubmed. Se decidió no actualizar la búsqueda de estudios, ya que el GEG consideró que la evidencia probablemente no ha cambiado en los últimos años. Por lo tanto, se decidió usar las RS identificadas por la GPC de Argentina (Liu 2017 y Adler 2014).

PICO 1.1: En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿se debería realizar actividad física mayor a 150 minutos semanales?

Evidencia: Se consideró la RS de Liu 2017 (18).

Beneficios: Por cada 1000 adultos sin hipertensión arterial que realicen actividad física mayor a 150 minutos semanales en lugar de actividad física menor a 150 minutos semanales, podría ser que se disminuya la incidencia de hipertensión arterial en 63 casos (IC95%: -86 a -39) aunque la evidencia es incierta. No se encontró evidencia para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, accidente cerebrovascular, infarto agudo al miocardio, cambio promedio de la presión arterial sistólica/diastólica y eventos adversos. Por lo tanto, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son grandes.

Daños: No se encontró evidencia sobre los potenciales daños. El GEG consideró que las lesiones mecánicas producto del ejercicio físico no tendrían relevancia clínicamente significativa en población sana, por lo tanto, su juicio fue trivial.

Recomendación: El GEG determinó que realizar actividad física con una duración mayor a 150 minutos semanales ofrece un mejor balance en comparación a realizar actividad física menos de 150 minutos semanales, puesto que los beneficios fueron considerados como grandes y lo daños como triviales. Por ello, el GEG, emitió una recomendación ***a favor*** de realizar actividad física mayor a 150 minutos semanales. Si bien la certeza global de la evidencia fue baja, el GEG consideró que la intervención implica ahorros extensos y probablemente sea aceptable y factible de implementar, es por ello, que esta recomendación fue ***fuerte***.

PICO 1.2: En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿se debería reducir el consumo de sal o sodio en la dieta?

Evidencia: Se consideró la RS de Adler 2014 (19).

Beneficios: Por cada 1000 adultos sin hipertensión arterial que reducen el consumo de sal en la dieta en lugar de no reducirlo, probablemente se disminuya la presión arterial diastólica en un promedio de 0.80 mmHg (IC95%: -1.37 a –0.23). Sin embargo, podría ser que no modifiquemos la mortalidad por todas las causas y el cambio promedio de la presión arterial sistólica. Por lo tanto, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son moderados.

Daños: No se tuvo información para los potenciales daños. El GEG consideró que, en su experiencia, los potenciales daños producidos por reducir el consumo de sal en la dieta no son clínicamente relevantes, por lo tanto, su juicio fue trivial.

Recomendación: El GEG determinó que reducir el consumo de sal en la dieta ofrece un mejor balance en comparación a no reducirlo, puesto que los efectos de los beneficios fueron considerados como moderados y lo daños como triviales. Por ello, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la intervención. Si bien la certeza global de la evidencia fue baja, el GEG consideró que la intervención implica ahorros extensos y probablemente sea aceptable y factible por el personal de salud, es por ello, que esta recomendación fue ***fuerte***.

BPC: En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, considerar realizar actividad física de intensidad moderada (caminar, trotar, andar en bicicleta o nadar) en sesiones no menores a 30 minutos de 5 a 7 días por semana. Como alternativa, puede efectuarse actividad física de intensidad vigorosa por un total de 75 minutos semanales, distribuidos en tres sesiones por semana.

BPC: En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial, considerar brindar consejería para la adopción de estilos de vida saludable:

- Evitar el consumo de alcohol
- Cese del tabaquismo
- Mantener un peso adecuado
- Mantener una alimentación saludable
- Reducción del estrés

IV.2 Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica?

Evidencia: Para responder esta pregunta, se realizó una búsqueda de revisiones sistemáticas incluidas en guías de práctica clínica o publicadas como artículos científicos, que hayan abordado alguno de los desenlaces críticos os importantes priorizados por el GEG.

PICO 2.1: En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa y sin comorbilidades de alto riesgo, ¿se debería iniciar terapia farmacológica con presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg?

Evidencia: Se consideró la RS de Hong 2018 (20).

Beneficios: En adultos sin comorbilidades de alto riesgo y con PAS basal entre 130 a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindarlo, podríamos no disminuir la mortalidad por todas las causas, mortalidad por evento cardiovascular e insuficiencia cardiaca. De igual forma, podríamos no disminuir los casos de accidente cerebrovascular e infarto de miocardio, aunque la evidencia es incierta. Por lo tanto, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son triviales.

Daños: En la RS no se encontró evidencia para los desenlaces relativos a daños para adultos sin comorbilidades con PAS basal entre 130 a 140 mmHg. El GEG consideró que, en su experiencia, los potenciales daños producidos por la intervención no son clínicamente relevantes, ya que los casos de hipotensión que podrían presentarse suelen ser eventos manejables a nivel clínico, por lo tanto, su juicio fue trivial.

Recomendación: El GEG consideró que al brindar tratamiento antihipertensivo en adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg en comparación con no brindar tratamiento, los beneficios y los daños son triviales. Por ello, el GEG decidió emitir una recomendación ***en contra*** de brindar tratamiento antihipertensivo en adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg. Debido a que la certeza general de la evidencia fue muy baja, se decidió emitir una recomendación ***condicional.***

PICO 2.2: En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa y sin comorbilidades ¿se debería iniciar terapia farmacológica con presión arterial sistólica basal mayor o igual a 140 mmHg?

Evidencia: Se consideró la RS de Sundström 2015 (21).

Beneficios: Por cada 1000 adultos sin comorbilidades y con PAS basal igual o mayor a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindarlo, probablemente se disminuyan en 9 casos de mortalidad por todas las causas (IC95%: -15 a -3). Sin embargo, probablemente no modifiquemos la mortalidad por evento cardiovascular y accidente cerebrovascular. Considerando el tamaño del efecto para el desenlace de mortalidad por todas las causas, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son grandes.

Daños: En la RS no se encontró evidencia para los desenlaces relativos a daños para adultos con PAS basal igual o mayor a 140 mmHg. A pesar de que no se encontró evidencia para el desenlace de hipotensión, el GEG consideró que, según su experiencia clínica, estos eventos son bastante frecuentes en este grupo poblacional. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de brindar la intervención en lugar del comparador fueron pequeños.

Recomendación: El GEG consideró que el brindar tratamiento antihipertensivo en personas con PAS basal igual o mayor a 140 mmHg en comparación con no brindar tratamiento tiene beneficios grandes y daños pequeños. Además, se consideró que la intervención sí sería aceptable para el personal de salud y las pacientes, y sí sería factible de implementar. Por ello, el GEG decidió emitir una recomendación ***a favor*** de brindar tratamiento antihipertensivo en adultos con PAS basal igual o mayor a 140 mmHg. A pesar de tener certeza baja, el GEG consideró que los beneficios superan ampliamente los daños y que la intervención tendría un gran impacto en la población priorizada, por ello consideraron más adecuado emitir una recomendación ***fuerte***.

PICO 2.3: En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa con diabetes mellitus tipo 2 ¿se debería iniciar terapia farmacológica con presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg?

Evidencia: Se consideró la RS de Brunström 2016 (22) . Además, se actualizó la búsqueda con 3 ECAs: Bi 2025 (23), Nam 2021 (24) y Böhm 2021 (25).

Beneficios: Por cada 1000 adultos con diabetes y PAS basal entre 130 a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindarlo, probablemente se disminuya en 9 los accidentes cerebrovasculares (IC95%: -14 a -4). Sin embargo, no modificaremos la mortalidad por todas las causas y probablemente no modifiquemos el infarto al miocardio. De igual forma, podría ser que no modifiquemos la insuficiencia cardiaca; y podría ser que no modifiquemos la mortalidad por todas las causas, aunque la evidencia es incierta. Por lo tanto, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son moderados.

Daños: Por cada 1000 adultos con diabetes y PAS basal entre 130 a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindarlo, podría ser que aumenten en 19 los eventos adversos de hipotensión (IC95%: +9 a +36). Sin embargo, podría ser que no modifiquemos los eventos de enfermedad renal crónica, aunque la evidencia es incierta. Por lo tanto, considerando que el tamaño del efecto de hipotensión, como evento adverso serio, fue pequeño y no se encontró diferencia significativa en otros desenlaces, el GEG consideró que los daños de la intervención son pequeños.

Recomendación: El GEG consideró que al brindar tratamiento antihipertensivo en adultos con diabetes y PAS basal entre 130 a 140 mmHg en comparación con no brindar tratamiento, los beneficios son moderados y los daños son pequeños. Adicionalmente, se consideró que la implementación de la intervención era factible y que probablemente también sería aceptable. Por ello, el GEG decidió emitir una recomendación ***a favor*** de brindar tratamiento antihipertensivo en esta población. Debido a que la certeza general de la evidencia fue muy baja, el GEG decidió emitir una recomendación ***condicional.***

PICO 2.4: En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa con diabetes mellitus tipo 2 ¿se debería iniciar terapia farmacológica con presión arterial sistólica basal mayor o igual a 140 mmHg?

Evidencia: Se consideró la RS de Brunström 2016 (22). Además, se actualizó la búsqueda con 3 ECAs: Bi 2025 (23), Nam 2021 (24) y Böhm 2021 (25).

Beneficios: Por cada 1000 adultos con diabetes y PAS basal igual o mayor a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindarlo, probablemente disminuyamos 17 casos de insuficiencia cardiaca (IC95%: -19 a -14) y 4 eventos de enfermedad renal crónica (IC95%: -8 a -1). Además, podría ser que se disminuyamos 7 eventos de accidente cerebrovascular (IC95%: -11 a -3) y 5 eventos de infarto de miocardio (IC95%: -8 a -2). Sin embargo, no se modificará la mortalidad por todas las causas. Sin embargo, probablemente no se modifique la mortalidad por evento cardiovascular. Por lo tanto, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son grandes.

Daños En adultos con diabetes y PAS basal igual o mayor a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindarlo, podría ser que no modifiquemos los eventos adversos de hipotensión. El GEG consideró que, en su experiencia, los potenciales daños producidos por la intervención son clínicamente relevantes, por lo que consideraron que los daños de la intervención con pequeños

Recomendación: El GEG consideró que al brindar tratamiento antihipertensivo en adultos con diabetes y PAS basal igual o mayor a 140 mmHg en comparación con no brindar tratamiento, los beneficios son grandes y los daños se consideraron son pequeños. Asimismo, se consideró que la implementación de la intervención es factible y aceptable. Por consiguiente, el GEG decidió emitir una recomendación ***a favor*** de brindar tratamiento antihipertensivo. A pesar de la certeza de la evidencia baja, el GEG consideró que, debido a los beneficios grandes, esta intervención tendría un impacto importante de brindarse en todas las personas con diabetes como método de prevención para evitar desenlaces críticos, por ello decidió emitir una recomendación ***fuerte***.

El GEG consideró que los beneficios clínicos de iniciar tratamiento antihipertensivo inician desde una presión arterial sistólica mayor o igual a 130 mmHg. Estos beneficios se vuelven más evidentes cuando la presión arterial supera los 140 mmHg. En función de esta evidencia, el GEG determinó recomendar el inicio de tratamiento farmacológico a partir de cifras de presión sistólica iguales o superiores a 130 mmHg.

PICO 2.5 y PICO 2.6: En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa con enfermedad renal crónica, ¿se debería iniciar terapia farmacológica con presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg o mayor o igual a 140 mmHg?

Evidencia: Al no encontrarse ninguna RS ni estudios primarios que respondan a la pregunta PICO, el GEG consideró emitir puntos de buena práctica clínica para responder a esta pregunta clínica.

BPC: En adultos con enfermedad renal crónica con presión arterial sistólica basal mayor o igual a 130 o presión diastólica basal mayor o igual a 80 mmHg, considerar iniciar terapia antihipertensiva

PICO 2.7: En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa con antecedente de evento cardiovascular, ¿se debería iniciar terapia farmacológica con presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg?

Evidencia: Se consideró la RS de Brunström 2019 (26).

Beneficios: Por cada 1000 adultos con antecedente de evento cardiovascular y PAS basal entre 130 a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindarlo, probablemente evitemos 8 muertes por todas las causas (IC95%: -15 a -1). Además, podría ser que disminuyamos 6 eventos de

accidente cerebrovascular (IC95%: -10 a -2) y 7 eventos de insuficiencia cardiaca (IC95%: -10 a -4). Asimismo, podría ser que disminuyamos 15 eventos de infarto de miocardio (IC95%: -24 a -3), aunque la evidencia es incierta. Sin embargo, podría ser que no modifiquemos la mortalidad por evento cardiovascular, aunque la evidencia es incierta. Por lo tanto, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son grandes.

Daños: Por cada 1000 adultos con antecedente de evento cardiovascular y PAS basal entre 130 a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindarlo, podría ser que aumenten en 15 los eventos adversos de hipotensión (IC95%: 0 a +39), aunque la evidencia es incierta. Sin embargo, podría ser que no modifiquemos los eventos de enfermedad renal avanzada, aunque la evidencia es incierta. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños son pequeños.

Recomendación: El GEG consideró que al brindar tratamiento antihipertensivo en adultos con antecedente de evento cardiovascular y PAS basal entre 130 a 140 mmHg en comparación con no brindar tratamiento, los beneficios son grandes y los daños de la hipotensión son pequeños. Adicionalmente, se consideró que era factible su implementación y sería aceptable la intervención de brindar tratamiento antihipertensivo. Por ello, el GEG decidió emitir una recomendación ***a favor*** de brindar tratamiento antihipertensivo en este subgrupo a partir de una medición de PAS basal igual o mayor a 130 mmHg. A pesar de la certeza general de la evidencia que fue muy baja, el GEG consideró que el impacto de los beneficios para este grupo es grande debido a los desenlaces cardiovasculares que evita, por lo que decidió emitir una recomendación ***fuerte.***

PICO 2.8: En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa con antecedente de evento cardiovascular, ¿se debería iniciar terapia farmacológica con presión arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg?

Evidencia: Al no encontrarse ninguna RS ni estudios primarios que respondan a la pregunta PICO, el GEG consideró quedarse con la recomendación de la pregunta 2.7.

BPC: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, considerar realizar análisis auxiliares que incluya, hemograma, creatinina sérica, perfil lipídico, glucosa sérica, examen completo de orina, electrolitos séricos, albuminuria (cociente albúmina/creatinina en orina), electrocardiograma de 12 derivadas con el objetivo de identificar el daño a órgano blanco y optimizar el tratamiento.

IV.3 Pregunta 3. En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

Evidencia: Para responder esta pregunta, se llevó a cabo una búsqueda de RS incluidas en guías de práctica clínica o publicadas como artículos científicos, que hayan abordado alguno de los desenlaces críticos o importantes priorizados por el GEG:

PICO 3.1: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿se debería realizar actividad física mayor a 150 minutos semanales?

Evidencia: Se consideró la RS de Lee et 2021 (27).

Beneficios: En adultos de 18 años a más con HTA esencial al realizar ejercicio físico igual o mayor a 150 minutos semanales en lugar de realizar ejercicio físico menor a 150 minutos semanales podríamos disminuir en 5.21 mmHg la PAS promedio (-7.66 a -2.76) y en 7.82 mmHg la PAD promedio (-11.16 a -4.47). El GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son grandes. Esto debido a que se observó una reducción de la presión arterial sistólica y diastólica, la cual podría impactar en la disminución de la incidencia de eventos cardiovasculares futuros.

Daños: En la RS no se encontró evidencia para los desenlaces relativos a daños. A pesar de ello, el GEG enfatizó en que, si bien la intervención podría estar asociado algunas lesiones menores en los pacientes, estas son manejables. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños son triviales.

Recomendación: El GEG consideró que, al realizar actividad física igual a mayor a 150 minutos semanales en comparación con menos de 150 minutos semanales, los beneficios fueron grandes y los daños, triviales. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de realizar actividad física al menos 150 minutos semanales. Si bien, la certeza global de la evidencia fue baja, el GEG consideró que la intervención probablemente aceptable y factible de implementar, por lo tanto, esta recomendación fue ***fuerte***.

PICO 3.2: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿se debería realizar reducir el consumo de sal en dieta?

Evidencia: Se consideró la RS de Graudal 2021 (28).

Beneficios: En adultos de 18 años a más con HTA esencial al consumir una dieta baja en sodio (< 2g/d) o sal (<5g/d) en comparación con una dieta alta en sodio (≥ 2g/d) o sal (≥ 5g/d) podríamos disminuir en 5.71 mmHg la PAS promedio (-6.67 a -4.74) y en 2.87 mmHg la PAD promedio (-3.41 a -2.32). El GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son grandes. Esto debido a que se observó una reducción de la presión arterial sistólica y diastólica, la cual podría impactar en la disminución de la incidencia de eventos cardiovasculares futuros.

Daños: En la RS no se encontró evidencia para los desenlaces relativos a daños para la PICO. A pesar de eso, el GEG, de acuerdo con su experiencia clínica, consideró que los daños potenciales de una baja ingesta de sodio o sal no son clínicamente relevantes. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños son triviales.

Recomendación: El GEG consideró que al consumir una dieta baja en sodio (< 2g/d) o sal (<5g/d) en comparación con una dieta alta en sodio (≥ 2g/d) o sal (≥ 5g/d), los beneficios fueron considerados moderados y los daños fueron considerados como pequeños. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del consumo de la dieta baja en sodio (< 2g/d) o sal (<5g/d). Si bien, la certeza global de la evidencia fue baja, el GEG consideró que la intervención es ampliamente aceptable y factible, por lo tanto, esta recomendación fue ***fuerte***.

BPC: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, considerar realizar actividad física cardiovascular de intensidad moderada (caminar, trotar, andar en bicicleta o nadar) en sesiones no menores a 30 minutos de 5 a 7 días por semana. Como alternativa, puede efectuarse actividad física de intensidad vigorosa por un total de 75 minutos semanales, distribuidos en tres sesiones por semana según la condición clínica individual.

BPC: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, considerar brindar consejería para la adopción de estilos de vida saludable:

- Evitar el consumo de alcohol
- Cese del tabaquismo
- Mantener un peso adecuado
- Adoptar un plan de alimentación para hipertensos.
- Reducción del estrés.

BPC: En adultos con hipertensión arterial, considerar el uso de la calculadora de riesgo HEARTS para la estimación del riesgo cardiovascular global.

IV.4 Pregunta 4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?

Evidencia: Se consideró la evidencia que proporcionó la Guía de Práctica Clínica (GPC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "*Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*" (7). Esta GPC realizó búsqueda de RS hasta 2019. Posteriormente, se actualizó la búsqueda de revisiones sistemáticas con periodo comprendido entre 2019 y 2025.

PICO 4.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?

Evidencia: Se consideró la RS de Yu 2025 (29), Yi 2024 (30), Wei 2020 (31).

IECA

Beneficios: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial sin comorbilidades que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo, evitaremos 8 casos de mortalidad por todas las causas (IC95%: -14 a -3), 7 casos de mortalidad por enfermedad cardiovascular (IC95%: -10 a -3) y 24 casos de infarto agudo al miocardio (IC95%: -36 a -11). De igual forma, podría ser que disminuyamos 11 casos de accidente cerebrovascular (IC95%: -17 a -5). El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo son grandes.

Daños: En adultos con hipertensión arterial sin comorbilidades que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo, probablemente no modifiquemos los casos de discontinuación por eventos adversos, tos y mareo. Adicionalmente, podríamos no modificar los casos de edema, hiperpotasemia e hipotensión, aunque la evidencia es incierta. El GEG consideró que los daños de recibir monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo son triviales.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva en monoterapia con IECA ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios fueron considerados como grandes y los daños triviales. Además, la intervención implica ahorros extensos y es aceptable y factible.

ARA II

Beneficios: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial sin comorbilidades que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlo, se podría disminuir en 6 casos la mortalidad por todas las causas (IC95%: -11 a -1) y 12 casos de accidente cerebrovascular (IC95%: -17 a -6). Sin embargo, podría ser que no modifiquemos los casos de mortalidad por enfermedad cardiovascular y probablemente no modifiquemos los casos de infarto agudo al miocardio. El GEG consideró que los beneficios de brindar monoterapia con ARA II son grandes.

Daños: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial sin comorbilidades que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlo, se podrían presentar 25 casos de mareo (IC95%: +4 a +52), 84 casos de hiperpotasemia (+16 a +180) y 75 casos de hipotensión (IC95%: +1 a +195), aunque la evidencia es incierta. Sin embargo, podríamos no modificar los casos de discontinuación por eventos adversos y tos. Adicionalmente, probablemente no modifiquemos los casos de edema. El GEG consideró que los daños de recibir monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlos son pequeños.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva en monoterapia con ARA II ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios fueron considerados como grandes y los daños pequeños. Además, la intervención implica costos moderados y es aceptable y factible.

BCC

Beneficios: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial sin comorbilidades que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con BCC en lugar de no recibirlo, se disminuye en 7 casos la mortalidad por todas las causas (IC95%: -11 a -2), 6 casos de mortalidad por enfermedad cardiovascular (IC95%: -9 a -3) y 15 casos de accidente cerebrovascular (IC95%: -19 a -11). Sin embargo, probablemente no modifiquemos los casos de infarto agudo al miocardio. El GEG consideró que los beneficios de brindar monoterapia con BCC son grandes.

Daños: El GEG consideró que los daños para los BCC son pequeños. Esto debido a que, si bien hubo mayor prevalencia de tos y edema en comparación a otros grupos farmacológicos (IECA, ARA II y diuréticos), la frecuencia para eventos de mareo e hipotensión fue similar respecto a otros grupos farmacológicos.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva en monoterapia con BCC ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios fueron considerados como grandes y los daños pequeños. Además, la intervención implica ahorros extensos y es aceptable y factible.

Diuréticos tiazídicos

Beneficios: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial sin comorbilidades que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con diuréticos tiazídicos en lugar de no recibirlo, se podría disminuir en 7 casos la mortalidad por todas las causas (IC95%: -11 a -2). Adicionalmente se disminuye 7 casos de mortalidad por enfermedad cardiovascular (IC95%: -11 a -4), 10 casos de infarto agudo al miocardio (IC95%: -19 a -1) y 16 casos de accidente cerebrovascular (IC95%: -21 a -12). El GEG consideró que los beneficios de brindar monoterapia con diuréticos tiazídicos son grandes.

Daños: El GEG consideró que los daños para los diuréticos tiazídicos son pequeños. Esto debido a que, la prevalencia de tos, mareos, edemas e hipotensión fue el promedio en comparación a otros grupos farmacológicos (IECA, ARA II y BCC).

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva en monoterapia con diuréticos tiazídicos ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios fueron considerados como grandes y los daños pequeños. Además, la intervención implica ahorros extensos y es aceptable y factible.

Recomendación: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo¥ que tienen indicaciones de monoterapia antihipertensiva, se recomienda brindar alguna de las siguientes alternativas:

- IECA: Baja (⊕⊕◯◯)
- ARA II: Muy baja (⊕◯◯◯
- BCC: Moderada (⊕⊕⊕◯)
- Diuréticos tiazídicos: Baja (⊕⊕◯◯)

Recomendación fuerte a favor

Consideraciones adicionales:

En caso de presentar eventos adversos no tolerables, considerar utilizar otro fármaco antihipertensivo de la lista.

¥ Las comorbilidades de alto riesgo incluyen diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o antecedente de enfermedad cardiovascular.

PICO 4.2: Adultos de 80 años o más con hipertensión arterial, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?

Evidencia: Se consideró la RS de Musini 2019 (32).

Beneficios: Por cada 1000 adultos mayores con hipertensión arterial mayores de 80 años que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia en lugar de no recibirlo, se disminuye en 10 casos de mortalidad por todas las causas (IC95%: -16 a -3), 5 casos de mortalidad por accidente cerebrovascular (IC95%: -7 a -3) y 7 casos de mortalidad por infarto agudo al miocardio (IC95%: -10 a -3). El GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son grandes.

Daños: Por cada 1000 adultos mayores con hipertensión arterial mayores de 80 años que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia en lugar de no recibirlo, se podrían presentar 103 casos de discontinuación por eventos adversos (IC95%: +24 a +124), certeza de la evidencia muy baja. El GEG consideró que los daños de recibir monoterapia en lugar de no recibirlos son pequeños.

Recomendación: El GEG determinó que brindar monoterapia ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios fueron considerados como grandes y lo daños como pequeños. Además, la intervención implica costos moderados y se consideró que son aceptables y factibles de implementar. Por ello, el GEG, emitió una recomendación ***a favor*** de la intervención. Debido a que la certeza general de la evidencia es baja, se decidió emitir una recomendación ***condicional***.

PICO 4.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?

Evidencia: Se consideró la RS de Remonti 2016 (33), Wu 2013 (34) y Zhang 2020 (35).

IECA

Beneficios: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo, se podría disminuir en 3 casos de progresión de enfermedad renal crónica (IC95%: -5 a -1). Sin embargo, podría ser que no modifiquemos los casos de mortalidad por todas las causas y mortalidad por evento cardiovascular. El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo son grandes.

Daños: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo, se podrían presentar 13 casos de tos (IC95%: +5 a +26) y probablemente se presentarán 8 casos de hipotensión (IC95%: +1 a +21). Sin embargo, podríamos no modificar los casos de hiperpotasemia y edema. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de recibir monoterapia con IECA en lugar de no recibirlos son pequeños.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva con IECA ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios fueron

considerados como grandes y los daños pequeños. Si bien la intervención implica costos extensos, esta es aceptable y factible de implementar.

ARA II

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlo, podríamos no modificar los casos de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y progresión a enfermedad renal crónica. El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo son triviales.

Daños: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlo, probablemente se presenten 11 casos de hiperpotasemia (IC95%: +5 a +20). Sin embargo, podríamos no modificar los casos de tos e hipotensión. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de recibir monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlos son pequeños.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva con ARA II no ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios y daños fueron considerados como triviales. Además, la intervención implica costos extensos y probablemente sea aceptable y factible.

BB

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con BB en lugar de no recibirlo, podríamos no modificar los casos de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y progresión a enfermedad renal crónica. El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con BB en lugar de no recibirlo son triviales.

Daños: El GEG consideró que los daños para los BB son triviales. Esto debido a que, si bien no se dispone de información, el GEG consideró que los BB usualmente no son un grupo farmacológico que se utiliza en este grupo poblacional especifico.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva con BB no ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios y daños fueron considerados como triviales. Además, la intervención implica costos extensos y probablemente es aceptable y factible.

BCC

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con BCC en lugar de no recibirlo, podríamos no modificar los casos de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y progresión a enfermedad renal crónica. El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con BCC en lugar de no recibirlo son triviales.

Daños: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con BCC en lugar de no recibirlo, probablemente se presenten 124 casos de edema (IC95%: +8 a +540). Sin embargo, podríamos no modificar los casos de hiperpotasemia, tos e hipotensión. El GEG consideró que los daños de recibir monoterapia con BCC en lugar de no recibirlos son pequeños.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia con BCC no ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios fueron considerados como triviales y los daños pequeños. Además, la intervención costos ahorros extensos y es probablemente aceptable y factible.

Diuréticos tiazídicos

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con diuréticos tiazídicos en lugar de no recibirlo, podríamos no modificar los casos de mortalidad por todas las causas y mortalidad por enfermedad cardiovascular. El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo son triviales.

Daños: En adultos con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con diuréticos tiazídicos en lugar de no recibirlo, podríamos no modificar los casos de hiperpotasemia. El GEG consideró que los daños de recibir monoterapia con diuréticos tiazídicos en lugar de no recibirlos son triviales.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva con diuréticos tiazídicos no ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios y daños fueron considerados como triviales. Además, la intervención implica costos extensos y es probablemente aceptable y factible.

Recomendación: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que tienen indicación de monoterapia antihipertensiva, se sugiere brindar:

- IECA: Baja (⊕⊕◯◯)

Consideraciones adicionales:
En caso de iniciar un IECA y presentar eventos adversos no tolerables, considerar utilizar un ARA II.

PICO 4.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?

Evidencia: Se consideró la RS de Zhang 2020 (35).

IECA

Beneficios: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo, probablemente se disminuyan 10 casos de mortalidad por todas las causas (IC95%: -15 a -4), 7 casos de mortalidad por enfermedad cardiovascular (IC95%: -10 a -4) y 10 casos de progresión a enfermedad renal crónica (IC95%: -13 a -6). El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo son grandes.

Daños: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo, se podrían presentar 13 casos de tos (IC95%: +5 a +26) y probablemente se presentarán 8 casos de hipotensión (IC95%: +1 a +21). Sin embargo, podríamos no modificar los casos de hiperpotasemia y edema. El GEG consideró que los daños de recibir monoterapia con IECA en lugar de no recibirlos son moderados.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva con IECA ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios fueron

considerados como grandes y los daños moderados. Además, la intervención implica ahorros extensos y es aceptable y factible.

ARA II

Beneficios: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlo, se podrían disminuir 5 casos de progresión a enfermedad renal crónica (IC95%: -9 a 0). Sin embargo, podríamos no modificar los casos de mortalidad por todas las causas y mortalidad por enfermedad cardiovascular. El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlos son moderados.

Daños: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlo, probablemente se presenten 11 casos de hiperpotasemia (IC95%: +5 a +20). Sin embargo, podríamos no modificar los casos de tos e hipotensión. El GEG consideró que los daños de recibir monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlos son pequeños.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia con ARA II ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios fueron moderados y daños pequeños. Además, a pesar de implicar costos extensos, es aceptable y factible de implementar.

BCC

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con BCC en lugar de no recibirlo, podríamos no modificar los casos de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y progresión a enfermedad renal crónica. El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con BCC en lugar de no recibirlo son triviales.

Daños: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con BCC en lugar de no recibirlo, probablemente se presenten 124 casos de edema (IC95%: +8 a +540). Sin embargo, podríamos no modificar los casos de hiperpotasemia, tos e hipotensión. El GEG consideró que los daños de recibir monoterapia con BCC en lugar de no recibirlos son pequeños.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva con BCC no ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios fueron considerados como triviales y los daños pequeños. Si bien es aceptable y factible implica costos extensos.

Diuréticos tiazídicos

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con diuréticos tiazídicos en lugar de no recibirla, podríamos no modificar los casos de mortalidad por todas las causas y progresión a enfermedad renal crónica. El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo son triviales.

Daños: En adultos con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con diuréticos tiazídicos, podríamos no modificar los casos de hiperpotasemia. El GEG consideró que los daños de recibir monoterapia con diuréticos tiazídicos en lugar de no recibirlos son triviales.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva con diuréticos tiazídicos no ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los

beneficios y daños fueron considerados como triviales. Si bien es aceptable y factible implica costos extensos.

Recomendación: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica estadio I al III[†] con albuminuria grado A1-A3[‡] que tienen indicaciones de monoterapia antihipertensiva, se recomienda brindar:

- IECA: Moderada (⊕⊕⊕◯)
- ARA II: Baja (⊕⊕◯◯)

Consideraciones adicionales:

En estadio IV y V, considerar individualizar el tratamiento de acuerdo con criterio clínico.}

[†] Tasa de filtración glomerular estimada: Grado 1 ≥ 90 mL/min/1.73 m2, Grado 2 entre 60 a 89 mL/min/1.73 m2, Grado 3a entre 45 a 59 mL/min/1.73 m2, Grado 3b entre 30 a 44 mL/min/1.73 m2, Grado 4 entre 15 a 29 mL/min/1.73 m2 y Grado 5 < 15 mL/min/1.73 m2.
[‡] Albuminuria: Grado A1: Normal o levemente incrementada <30 mg/g, Grado A2: moderadamente incrementada entre 30 a 299 mg/g y A3: severamente incrementada > a 300 mg/g.

PICO 4.5: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, ¿qué grupo de fármacos en monoterapia se debería brindar como tratamiento antihipertensivo en primera línea?

Evidencia: Se consideró la RS de Xie 2018 (36) y Wang 2016 (37).

IECA

Beneficios: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo, se disminuyen 13 casos de mortalidad por todas las causas (IC95%: -19 a -6). Sin embargo, podríamos no modificar los casos de infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular. El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo son grandes.

Daños: En adultos con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con IECA en lugar de no recibirlo, podríamos no modificar los casos de eventos adversos. El GEG consideró que los daños de recibir monoterapia con IECA en lugar de no recibirlos son triviales.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva con IECA ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios fueron considerados como grandes y los daños triviales. Si bien la intervención implica costos extensos, es ampliamente aceptable y factible.

ARA II

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlos, no reduciremos los casos de mortalidad por todas las causas. Adicionalmente, podríamos no reducir los casos de infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular. El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlos son triviales

Daños: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlo, se podrían presentar 25 casos de mareos (IC95%: +4 a +52), 84 casos de hiperpotasemia (IC95%: +16 a +180) y

75 casos de hipotensión (IC95%: +1 a +195). Sin embargo, podríamos no modificar los casos de discontinuación por eventos adversos serios, tos y edema. El GEG consideró que los daños de recibir monoterapia con ARA II en lugar de no recibirlos son moderados.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva en monoterapia con ARA II no ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios fueron triviales y daños moderados. Si bien es aceptable y factible implica costos extensos.

BB

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con BB en lugar de no recibirlos, podríamos no reducir los casos de mortalidad por todas las causas infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular. El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con BB en lugar de no recibirlos son triviales

Daños: El GEG consideró que los daños para los BB son triviales. Esto debido a que, la frecuencia de tos, mareos, edemas e hipotensión fue similar en comparación con otros grupos farmacológicos (IECA, ARA II, BCC y diuréticos).

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva en monoterapia con BB no ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios y daños fueron considerados como triviales. Si bien es aceptable y factible implica costos extensos.

BCC

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con BCC en lugar de no recibirlos, no reduciremos los casos de mortalidad por todas las causas. Adicionalmente, podríamos no reduciremos los casos de infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular. El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con BCC en lugar de no recibirlos son triviales

Daños: El GEG consideró que los daños para los BCC son pequeños. Esto debido a que, si bien hubo mayor prevalencia de tos y edema en comparación a otros grupos farmacológicos (IECA, ARA II, BB y diuréticos), la prevalencia para eventos de mareo e hipotensión fue similar en comparación a otros grupos farmacológicos.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva en monoterapia con BCC no ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios fueron considerados como triviales y los daños pequeños. Si bien es aceptable y factible implica costos extensos.

Diuréticos tiazídicos

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular que reciben tratamiento antihipertensivo en monoterapia con diuréticos tiazídicos en lugar de no recibirlos, no reduciremos los casos de mortalidad por todas las causas. Adicionalmente, podríamos no reduciremos los casos de infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular. El GEG consideró que los beneficios de recibir monoterapia con diuréticos tiazídicos en lugar de no recibirlos son triviales

Daños: El GEG consideró que los daños para los diuréticos son triviales. Esto debido a que, la prevalencia de tos, mareos, edemas e hipotensión fue similar en comparación a otros grupos farmacológicos (IECA, ARA II, BB y BCC).

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar monoterapia antihipertensiva en monoterapia con diuréticos tiazídicos no ofrece un mejor balance en comparación a no recibirlo, puesto que, los efectos de los beneficios y daños fueron considerados como triviales. Si bien es aceptable y factible implica costos extensos.

Recomendación: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular que tienen indicación de monoterapia antihipertensiva, se sugiere brindar:

- IECA: Baja (⊕⊕◯◯)

IV.5 Pregunta 5. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo en terapia combinada o monoterapia?

Evidencia: Se consideró la evidencia que proporcionó la Guía de Práctica Clínica (GPC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) *"Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults"* (7). Esta GPC realizó una búsqueda de RS hasta 2019. Posteriormente, se actualizó la búsqueda de RS con periodo comprendido entre 2019 y 2025. Sin embargo, debido a que solo se identificó una RS (38) que incluyó bajo número de participantes, bajo número de eventos y un único esquema terapéutico para terapia combinada, el GEG consideró emitir un punto de buena práctica clínica.

BPC: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial considerar brindar terapia combinada a dosis baja como tratamiento antihipertensivo inicial.

IV.6 Pregunta 6. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?

Evidencia: Se consideró la evidencia que proporcionó la guía de Organización Mundial de la Salud (OMS) "*Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*" (7). Esta GPC realizó búsqueda de revisiones sistemáticas hasta 2019. Posteriormente, se actualizó la búsqueda de revisiones sistemáticas con un periodo comprendido entre 2019 y 2025.

PICO 6.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?

Evidencia: Se consideró la RS de Yu 2025 (29) y los ECA de Thijs 2010 (39), Dahlof 2005 (40), Mogensen 2003 (41) y STOP-H2 1999 (42).

IECA + BCC

Beneficios: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y sin comorbilidades que reciben terapia combinada con IECA + BCC en lugar de monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos) se disminuye entre 19 a 37 casos de mortalidad por todas las causas. Adicionalmente, recibir terapia combinada con IECA + BCC en lugar de terapia combinada (ARA II + diuréticos tiazídicos), disminuiremos 17 casos de mortalidad por todas las causas (IC95%: -26 a -6). Sin embargo, podríamos no modificar la mortalidad por enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. El GEG consideró que los beneficios de recibir terapia combinada con IECA + BCC en lugar de monoterapia u otras terapias combinadas son grandes.

Daños: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y sin comorbilidades que reciben terapia combinada con IECA + BCC en lugar de monoterapia (BCC), se podrían presentar 27 casos de hipotensión (IC95%: +9 a +54), 33 casos de tos (IC95%: +12 a +63) y 27 casos de edema (IC95%: +4 a +58). No se reportó información para comparaciones con otras terapias combinadas. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de recibir terapia combinada con IECA + BCC en lugar de monoterapia son pequeños.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar terapia combinada con IECA + BCC ofrece un mejor balance en comparación a monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos) o terapia combinada (ARA II + diuréticos tiazídicos), puesto que, los efectos de los beneficios fueron considerados como grandes y los daños pequeños. Además, la intervención implica ahorros extensos y es aceptable y factible.

IECA + diuréticos tiazídicos

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial sin comorbilidades que reciben terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos), podríamos no modificar los casos de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. De igual forma, recibir terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos en lugar de terapia combinada con ARA II + diuréticos tiazídicos, podríamos no modificar la mortalidad por todas las causas, mortalidad por evento cardiovascular y accidente cerebrovascular. Sin embargo, el GEG consideró que existen potenciales efectos deseables en desenlaces no evaluados, por lo cual, consideró que los beneficios de brindar terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia son pequeños.

Daños: En adultos con hipertensión arterial y sin comorbilidades que reciben terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia con diuréticos tiazídicos, podríamos no modificar los casos de discontinuación por eventos adversos, hipotensión y cambio promedio de la tasa de filtración glomerular. No se reportó información para comparaciones con otras terapias combinadas. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de recibir terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia son triviales.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos, no ofrece un mejor balance en comparación a monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos) u otras terapias combinadas, puesto que, los efectos de los beneficios fueron considerados como pequeños y los daños triviales. Si bien, la intervención es aceptable y factible, implica costos moderados.

ARA II + BB

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial sin comorbilidades que reciben terapia combinada con ARA II + BB en lugar de monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos), podríamos no modificar los casos de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. Adicionalmente, recibir terapia combinada con ARA II + BB en lugar de terapia combinada con ARA II + diuréticos tiazídicos, podríamos no modificar la mortalidad por todas las causas, mortalidad por evento cardiovascular y accidente cerebrovascular. El GEG consideró que los beneficios de brindar terapia combinada con ARA II + BB en lugar de monoterapia u otras terapias combinadas son triviales.

Daños: El GEG consideró que los daños para los ARA II + BB son pequeños. Esto debido a que, si bien no se encontró evidencia, el GEG en su experiencia clínica ha observado efectos indeseables pequeños.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar terapia combinada con ARA II + BB, no ofrece un mejor balance en comparación a monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos) u otras terapias combinadas, puesto que, los efectos de los beneficios y daños fueron considerados como triviales. Si bien, la intervención es aceptable y factible, implica costos moderados.

BB + diuréticos tiazídicos

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial sin comorbilidades que reciben terapia combinada con BB + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos), podríamos no modificar los casos de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. Adicionalmente, recibir terapia combinada con BB + diuréticos tiazídicos en lugar de terapia combinada con ARA II + diuréticos tiazídicos, podríamos no modificar la mortalidad por todas las causas, mortalidad por evento cardiovascular y accidente cerebrovascular. El GEG consideró que los beneficios de brindar terapia combinada con BB + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia u otras terapias combinadas son triviales.

Daños: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial y sin comorbilidades que reciben terapia combinada con BB + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia con IECA, se podrían disminuir 265 casos de tos (IC95%: -274 a -256). Adicionalmente, al realizar la comparación con ARA II, se podrían disminuir 20 casos de tos (IC95%: -29 a -9) y 171 casos de edema (IC95%: -181 a -156), aunque la evidencia es incierta. No se reportó información para comparaciones con otras terapias combinadas. Por lo tanto, e El GEG consideró que los daños de recibir terapia combinada con BB + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia son triviales.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar terapia combinada con BB + diuréticos tiazídicos, no ofrece un mejor balance en comparación a monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos) u otras terapias combinadas, puesto que, los efectos de los beneficios y daños fueron considerados como triviales. Si bien, la intervención es aceptable y factible, implica costos moderados.

ARA II + BCC

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial que reciben tratamiento antihipertensivo en terapia combinada con ARA II + BCC en lugar de monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos), podríamos no modificar los casos de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. Adicionalmente, recibir terapia combinada con ARA II + BCC en lugar de terapia combinada con ARA II + diuréticos tiazídicos, podríamos no modificar la mortalidad por todas las causas, mortalidad por evento cardiovascular y accidente cerebrovascular. El GEG consideró que los beneficios de brindar ARA II + BCC en lugar de monoterapia u otras terapias combinadas son triviales.

Daños: El GEG consideró que los daños para los ARA II + BCC son pequeños, esto debido a que no se reportó evidencia para efectos indeseables.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar terapia combinada con ARA II + BCC, no ofrece un mejor balance en comparación a monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos) u otras terapias combinadas, puesto que, los efectos de los beneficios fueron triviales y los daños fueron considerados como pequeños. Si bien, la intervención es aceptable y factible, implica costos moderados.

ARA II + diuréticos tiazídicos

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial que reciben tratamiento antihipertensivo en terapia combinada con ARA II + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos

tiazídicos), podríamos no modificar los casos de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. Adicionalmente, recibir terapia combinada con ARA II + diuréticos tiazídicos en lugar de otras alternativas de terapia combinada, podríamos no modificar la mortalidad por todas las causas, mortalidad por evento cardiovascular y accidente cerebrovascular. El GEG consideró que los beneficios de brindar ARA II + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia u otras terapias combinadas son triviales.

Daños: El GEG consideró que los daños para los ARA II + diuréticos tiazídicos son pequeños, esto debido a que no se reportó evidencia para efectos indeseables.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar terapia combinada con ARA II + diuréticos tiazídicos, no ofrece un mejor balance en comparación a monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos) u otras terapias combinadas, puesto que, los efectos de los beneficios fueron triviales y los daños fueron considerados como pequeños. Si bien, la intervención es aceptable y factible, implica costos moderados.

Recomendación: El GEG determinó que las combinaciones terapéuticas que incluyen ARA II + BCC y ARA II + diuréticos tiazídicos se basan exclusivamente en estimaciones indirectas derivadas del metaanálisis en red. En consecuencia, la precisión de los desenlaces evaluados pudo haberse visto comprometida debido a la menor potencia estadística asociada a este tipo de evidencia. Por otra parte, los ARA II presentan una eficacia antihipertensiva comparable a la de los IECA, actúan sobre el mismo sistema fisiológico y muestran perfiles de seguridad equivalentes. En virtud de ello, el GEG consideró a los ARA II como una alternativa apropiada en casos de intolerancia a los IECA.

En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo que tienen indicación de terapia combinada a bajas dosis, se sugiere brindar:

- IECA/ARA II + BCC (Baja ⊕⊕◯◯)
- IECA/ARA II+ diuréticos tiazídicos (Baja ⊕⊕◯◯)

Consideraciones adicionales:

En caso de presentar eventos adversos no tolerables, considerar el uso de otro esquema antihipertensivo de la lista.

PICO 6.2: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?

Evidencia: Se consideró la RS de Remonti 2016 (33), la RS de Wu 2013 (43) y los ECA de Mogensen 2003 (41) y Fogari 2002 (44).

IECA + diuréticos tiazídicos

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que reciben terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia (IECA o ARA II) o terapia combinada (IECA + BCC), podríamos no modificar los casos de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y cambio promedio de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, El GEG consideró que podrían existir potenciales efectos deseables de recibir terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos en lugar de recibir monoterapia en desenlaces no evaluados, por lo tanto, los beneficios fueron considerados como pequeños.

Daños: En adultos con hipertensión arterial que reciben terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia con diuréticos, podríamos no modificar los casos de discontinuación por eventos adversos, hipotensión y cambio en la creatinina. No se reportó información para comparaciones con otras terapias combinadas. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de recibir terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia son triviales.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos ofrece un mejor balance en lugar de monoterapia con (IECA o ARA II) o terapia combinada (IECA + BCC), puesto que, los efectos de los beneficios son pequeños y daños fueron considerados como triviales. Además, implica costos moderados y es aceptable y factible.

IECA + BCC

Beneficios: Por cada 1000 adultos con hipertensión arterial que reciben terapia combinada con IECA + BCC en lugar de monoterapia con ARA II, probablemente disminuyamos 53 casos de mortalidad por evento cardiovascular (IC95%: -64 a -6). Sin embargo, no modificaremos los casos de mortalidad por todas las causas y mortalidad por enfermedad cardiovascular al compararlo con monoterapia con IECA o con terapia combinada (IECA + diuréticos tiazídicos). El GEG consideró que los beneficios de recibir terapia combinada con IECA + BCC en lugar de recibir monoterapia u otras terapias combinadas son grandes.

Daños: En adultos con hipertensión arterial que reciben terapia combinada con IECA + BCC en lugar de monoterapia con IECA, no modificaremos los casos de tos. No se reportó información para comparaciones con otras terapias combinadas. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de recibir terapia combinada con IECA + BCC en lugar de monoterapia son triviales.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar terapia combinada con IECA + BCC ofrece un mejor balance en lugar de monoterapia con ARA II o terapia combinada (IECA + diuréticos tiazídicos), puesto que, los efectos de los beneficios son grandes y daños fueron considerados como triviales. Además, implica costos moderados y es aceptable y factible.

Recomendación: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que tienen indicación de terapia combinada a dosis bajas, se sugiere brindar:

- IECA/ARA II + BCC: Baja (⊕⊕◯◯)
- IECA/ARA II + diuréticos tiazídicos: Muy baja (⊕◯◯◯)

Consideración adicional:

En caso de presentar eventos adversos no tolerables, considerar el uso de otro esquema antihipertensivo de la lista.

PICO 6.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?

BPC: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica estadio I al III[†] con albuminuria grado A1-A3[‡], considerar como tratamiento inicial terapia combinada a dosis bajas de:

- IECA o ARA II en combinación con BCC o diuréticos

Consideraciones adicionales:

En estadio IV y V, considerar individualizar el tratamiento de acuerdo con criterio clínico.

[†] Tasa de filtración glomerular estimada: Grado 1 ≥ 90 mL/min/1.73 m2, Grado 2 entre 60 a 89 mL/min/1.73 m2, Grado 3a entre 45 a 59 mL/min/1.73 m2, Grado 3b entre 30 a 44 mL/min/1.73 m2, Grado 4 entre 15 a 29 mL/min/1.73 m2 y Grado 5 < 15 mL/min/1.73 m2.

[‡] Albuminuria: Grado A1: Normal o levemente incrementada <30 mg/g, Grado A2: moderadamente incrementada entre 30 a 299 mg/g y A3: severamente incrementada > a 300 mg/g.

PICO 6.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?

Evidencia: Se consideró la RS de Wang 2016 (37) y los ECA de Mogensen 2003 (41) y Fogari 2002 (44).

IECA + diuréticos tiazídicos

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular que reciben terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia con IECA o terapia combinada (diuréticos tiazídicos + BB), podríamos no modificar los casos de infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular. Sin embargo, se reportaron beneficios al compararlo con placebo. En este sentido, el GEG consideró que existen potenciales efectos deseables de recibir terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos en lugar de recibir monoterapia son pequeños.

Daños: En adultos con hipertensión arterial que reciben terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos en lugar de monoterapia con diuréticos, podríamos no modificar los casos de discontinuación por eventos adversos, hipotensión y cambio en la creatinina. No se reportó información para comparaciones con otras terapias combinadas. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de recibir terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos en lugar de no recibirlo son triviales.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos ofrece un mejor balance en comparación a la monoterapia (IECA) y terapia combinada (diuréticos tiazídicos + BB), puesto que, los efectos de los beneficios fueron considerados como pequeños y los daños triviales. Además, la intervención implica costos extensos y probablemente es aceptable y factible.

Diuréticos tiazídicos + BB

Beneficios: En adultos con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular que reciben terapia combinada con diuréticos tiazídicos + BB en lugar de monoterapia con IECA o terapia combinada (IECA + diuréticos tiazídicos), podríamos no modificar los casos de infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular. En este sentido, el GEG consideró que los potenciales efectos deseables de recibir terapia combinada con diuréticos tiazídicos + BB en lugar de recibir monoterapia o terapia combinada son triviales.

Daños: En adultos con hipertensión arterial que reciben terapia combinada con diuréticos tiazídicos + BB en lugar de monoterapia con IECA, podríamos no modificar los casos de tos. No se reportó información para comparaciones con otras terapias combinadas. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de recibir terapia combinada con diuréticos tiazídicos + BB en lugar de no recibirlo son triviales.

Balance de los efectos: El GEG determinó que brindar terapia combinada con diuréticos tiazídicos + BB no ofrece un mejor balance en comparación a la monoterapia con IECA y terapia combinada con IECA + diuréticos tiazídicos, puesto que, los efectos de los beneficios y daños son triviales. Además, la intervención implica costos extensos y probablemente es aceptable y factible.

Recomendación: El GEG consideró que, ante la falta de evidencia para las combinaciones que incluyen ARA II, sería adecuado considerar a los ARA II como una opción equivalente a los IECA en ambas combinaciones terapéuticas. Esta decisión se basa en que ambos medicamentos muestran una eficacia antihipertensiva similar, actúan sobre el mismo sistema fisiológico y presentan perfiles de seguridad comparables. Asimismo, el GEG consideró incluir la combinación IECA/ARA II + BCC como

alternativa, puesto que, aunque no se identificaron estudios con evidencia disponible, la práctica clínica sugiere beneficios consistentes asociados a esta estrategia terapéutica.

En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular que tienen indicación de terapia combinada, se sugiere brindar:

- IECA/ARA II + diuréticos tiazídicos

Consideraciones adicionales:

Considerar como alternativa: IECA/ARA II + BCC.

BPC: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad coronaria considerar brindar terapia combinada con IECA/ARA II + BB

BPC: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad arterial periférica considerar brindar terapia combinada con IECA/ARA II + BCC

IV.7 Pregunta 7. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser el objetivo de presión arterial?

Evidencia: Se consideró la evidencia que proporcionó la Guía de Práctica Clínica (GPC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) *"Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults"* (7). Esta GPC realizó una búsqueda de RS hasta 2019. Posteriormente, se actualizó la búsqueda de RS con periodo comprendido entre 2019 y 2025. En la actualización de la búsqueda, se encontraron RS que respondían a las preguntas PICO; sin embargo, algunos presentaban alta heterogeneidad, por lo que se extrajeron los ECAs que se ajustaban a los criterios de selección y se realizaron nuevos metaanálisis.

PICO 7.1: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser el objetivo de presión arterial?

Evidencia: Se consideraron los ECA de Verdecchia 2009 (45), Asayama 2012 (46), SPRINT 2021 (47) y Liu 2024 (48).

Beneficios: Por cada 1000 adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, al considerar un objetivo de PAS < 130mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 130 y 140mmHg, podríamos reducir la mortalidad por todas las causas en 8 casos menos (IC95%: -13 a -3), la mortalidad por enfermedad cardiovascular en 6 casos menos (IC95%: -10 a -3), el infarto agudo de miocardio en 4 casos menos (IC95%: -9 a -1) y la insuficiencia cardíaca en 6 casos menos (IC95%: -10 a -2). Sin embargo, probablemente no modifiquemos los accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son grandes.

Daños: Por cada 1000 adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, al considerar un objetivo de PAS < 130mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 130 y 140mmHg, podríamos aumentar la hipotensión en 4 casos más (IC95%: +2 a +6), la injuria renal aguda en 8 casos más (IC95%: +5 a +10) y la reducción de la tasa de filtración glomerular en 34 casos más (IC95%: +29 a +38). Sin embargo, podríamos no modificar los eventos adversos serios y podríamos no modificar los eventos adversos grados 3 y 4 aunque la evidencia es incierta. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de brindar la intervención son pequeños.

Recomendación: El GEG determinó que, en adultos mayores de 18 años o más con hipertensión arterial, considerar un objetivo de PAS < 130mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 130 y 140mmHg, representa beneficios grandes y daños pequeños. Además, implican costos similares, y probablemente sean aceptables ni factibles de implementar en la mayoría de los establecimientos de

salud. Por ello, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la intervención. Debido a que la certeza general de la evidencia es baja, se decidió emitir una recomendación ***condicional***.

Consideraciones adicionales:

En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 80 mmHg.

PICO 7.2: En adultos de 65 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser el objetivo de presión arterial?

Evidencia: Se consideraron los ECA de JATOS 2008 (49), VALISH 2010 (50), Wei 2013 (51) y STEP 2021 (52).

Beneficios: Por cada 1000 adultos de 65 años o más con hipertensión arterial, al considerar un objetivo de PAS < 140mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 140 y 150mmHg, probablemente reduzcamos la mortalidad por enfermedad cardiovascular en 4 casos menos (IC95%: -6 a -1), el accidente cerebrovascular en 5 casos menos (IC95%: -8 a -1) y la insuficiencia cardíaca en 112 casos menos (IC95%: -158 a -24). Sin embargo, probablemente no modifiquemos el infarto agudo al miocardio, podría ser que no modifiquemos la mortalidad por todas las causas. Por lo tanto, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son grandes.

Daños: Por cada 1000 adultos de 65 años o más con hipertensión arterial, al considerar un objetivo de PAS < 140mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 140 y 150mmHg, podríamos aumentar la hipotensión en 4 casos más (IC95%: +2 a +6). Sin embargo, probablemente no modifiquemos los eventos adversos grado 3 y 4, y podríamos no modificar los eventos adversos serios y la reducción de la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de la intervención son pequeños.

Recomendación: El GEG determinó que, en adultos de 65 años o más con hipertensión arterial, considerar un objetivo de PAS < 140mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 140 y 150mmHg, representa beneficios grandes y daños pequeños. Además, implican ahorros extensos, y son aceptables y factibles de implementar en la mayoría de los establecimientos de salud. Por ello, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la intervención. Debido a que la certeza general de la evidencia es baja, se decidió emitir una recomendación ***condicional***.

Consideraciones adicionales:

En adultos de 65 años o más con hipertensión arterial, considerar un objetivo de presión arterial diastólica menor a 90 mmHg.

BPC: En adultos de 80 años o más con hipertensión arterial, se podría considerar una meta de presión arterial entre 140 a 150 mmHg de manera individualizada y según juicio clínico.

PICO 7.3: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y diabetes mellitus tipo 2, ¿cuál debería ser el objetivo de presión arterial?

Evidencia: Se consideraron los ECA de ACCORD 2010 (53), SPS 2013 (54), ADDITION 2019 (55) y BPROAD 2025 (23).

Beneficios: Por cada 1000 adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, al considerar un objetivo de PAS < 130mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 130 y 140mmHg, reduciremos los accidentes cerebrovasculares en 10 casos menos (IC95%: -16 a -3). Sin embargo, no reduciremos la mortalidad por todas las causas, ni el infarto agudo al miocardio y probablemente no

reduciremos la mortalidad por enfermedad cardiovascular ni la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son moderados.

Daños: Por cada 1000 adultos de 65 años o más con hipertensión arterial, al considerar un objetivo de PAS < 130mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 130 y 140mmHg, probablemente aumentemos 3 casos de hipotensión (IC95%: +1 a +15). Sin embargo, podría ser que no modifiquemos los eventos adversos serios, ni la injuria renal aguda, aunque la evidencia es incierta. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de la intervención son pequeños.

Recomendación: El GEG determinó que, en adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, considerar un objetivo de PAS < 130mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 130 y 140mmHg, representa beneficios moderados y daños pequeños. Además, implican ahorros extensos, y son aceptables y factibles de implementar en la mayoría de los establecimientos de salud. Por ello, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la intervención. Debido a que la certeza general de la evidencia es baja, se decidió emitir una recomendación ***condicional***.

Consideraciones adicionales:

En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, considerar un objetivo de presión arterial diastólica menor a 80 mmHg.

PICO 7.4: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y enfermedad renal crónica, ¿cuál debería ser el objetivo de presión arterial?

Evidencia: Se consideraron los ECA de MDRD 1994 (56), AASK 2002 (57), REIN-2 2005 (58), ACCORD 2010 (53), SPS3 2013 (54) y Cheung 2017(59).

Beneficios: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, al considerar un objetivo de PAS < 130mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 130 y 140mmHg, probablemente no reduciremos la mortalidad por todas las causas, ni la mortalidad por enfermedad cardiovascular y podríamos no reducir los accidentes cerebrovasculares, los infartos agudos al miocardio ni la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son pequeños.

Daños: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, al considerar un objetivo de PAS < 130mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 130 y 140mmHg, no modificaremos los casos de reducción de la tasa de filtración glomerular, probablemente no modifiquemos los eventos adversos serios y podría ser que no modifiquemos la hipotensión. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de la intervención son triviales.

Recomendación: El GEG determinó que el balance de los beneficios y daños probablemente favorece a la intervención, puesto que, si bien los beneficios no fueron estadísticamente significativos, los estimados puntuales favorecen a la intervención en todos los desenlaces y los daños fueron considerados triviales. Por ello, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la intervención. Debido a que la certeza general de la evidencia es baja, se decidió emitir una recomendación ***condicional***.

Consideraciones adicionales:

En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, considerar un objetivo de presión arterial diastólica menor a 80 mmHg.

PICO 7.5: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y antecedente de enfermedad cardiovascular, ¿cuál debería ser el objetivo de presión arterial?

Evidencia: Se consideraron los ECA de ACCORD 2010 (53), SPS 2013 (54), SPRINT 2021 (47), RESPECT 2019 (60) y PRESERV 2021 (61).

Beneficios: Por cada 1000 adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular, al considerar un objetivo de PAS < 130mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 130 y 140mmHg, probablemente reduciremos los accidentes cerebrovasculares en 18 casos menos (IC95%: -31 a -1). Sin embargo, probablemente no reduciremos la mortalidad por todas las causas y podríamos no reducir la mortalidad por enfermedad cardiovascular, ni el infarto agudo al miocardio. Por lo tanto, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son moderados.

Daños: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular, al considerar un objetivo de PAS < 130mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 130 y 140mmHg, probablemente no modifiquemos los eventos adversos serios y podría ser que no modifiquemos la hipotensión. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños de la intervención son triviales.

Recomendación: El GEG determinó que, adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular, considerar un objetivo de PAS < 130mmHg en lugar de un objetivo de PAS entre 130 y 140mmHg, representa beneficios moderados y daños triviales. Además, implican ahorros extensos, y son aceptables y probablemente sean factibles de implementar en la mayoría de los establecimientos de salud. Por ello, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la intervención. Debido a que la certeza general de la evidencia es baja, se decidió emitir una recomendación ***condicional***.

Consideraciones adicionales:

En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular, considerar una meta de presión arterial diastólica menor igual a 80 mmHg.

IV.8 Pregunta 8. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?

Evidencia: Se consideró la evidencia que proporcionó la Guía de Práctica Clínica (GPC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) *"Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults"* (7). Esta GPC realizó una búsqueda de RS hasta 2019. Posteriormente, se actualizó la búsqueda de revisiones sistemáticas con periodo comprendido entre 2019 y 2025. En la actualización de la búsqueda, no se encontraron nuevas RS por lo que se consideró como evidencia lo sintetizado por la GPC de la OMS.

PICO 8.1: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?

Evidencia: Se consideró el EO de Xu 2015 (62).

Beneficios: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o cambian de tratamiento antihipertensivo, al considerar un control de la presión arterial cada mes en lugar de cada tres meses, se obtuvieron beneficios para mortalidad por todas las causas. Por lo tanto, el GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador son moderados.

Daños: Debido a la naturaleza de la intervención, el GEG no consideró necesario priorizar desenlaces sobre daños. Por lo tanto, fueron considerados como triviales.

Recomendación: El GEG determinó que el balance de los beneficios y daños probablemente favorece a la intervención, puesto que los efectos en la mortalidad por todas las causas fueron moderados y los daños fueron considerados triviales. Además, implican costos similares, y probablemente sean aceptables y factibles de implementar en la mayoría de los establecimientos de salud. Por ello, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la intervención. Debido a que la certeza general de la evidencia es baja, se decidió emitir una recomendación ***condicional***.

PICO 8.2: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que alcancen objetivo terapéutico, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?

Evidencia: Se consideró el ECA de Birtwhistle 2004 (63).

Beneficios: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que alcancen objetivo terapéutico, al considerar un control de presión arterial cada 3 meses en lugar de cada 6 meses, podría ser que no modifiquemos la adherencia al tratamiento antihipertensivo ni el control de los valores de la presión arterial. Considerando esta evidencia, el GEG expresó que, según su experticia clínica en el contexto peruano, el monitoreo precoz podría tener beneficios para la evaluación de los pacientes. Por lo tanto, el GEG consideró que el beneficio de brindar la intervención en lugar del comparador es pequeño.

Daños: Debido a la naturaleza de la intervención, el GEG no consideró necesario priorizar desenlaces sobre daños. Por lo tanto, fueron considerados como triviales.

Recomendación: El GEG determinó que realizar el control de presión arterial cada 3 meses en lugar de cada 6 meses presenta un mejor balance de efectos, puesto que, si bien los beneficios no fueron estadísticamente significativos, fueron considerados como pequeños en función a su experticia clínica. Esto debido a que el estudio utilizado como cuerpo de evidencia presentó limitaciones. Los daños fueron considerados triviales. Por ello, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la intervención y debido a que la certeza general de la evidencia es muy baja, se decidió emitir una recomendación ***condicional***.

Consideraciones adicionales:

En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que presenten signos clínicos de presión arterial no controlada, considerar realizar la reevaluación de la presión arterial según juicio clínico.

V. PLAN PARA LA ACTUALIZACION DE LA GPC

La presente GPC tiene una vigencia de cinco años. Al acercarse al fin de este período, el CETS del Instituto Nacional de Salud procede a valorar el tipo de actualización requerida (completa, parcial, retirada) conforme al Documento Técnico Metodología para la elaboración de Guías de Práctica Clínica aprobado por el Ministerio de Salud con Resolución Ministerial N° 414-2015- MINSA o la que haga sus veces.

VI. PLAN PARA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GPC

Las actividades para la evaluación y monitoreo de la Guía de Práctica Clínica se diseñan conforme a las disposiciones normativas que emita el Instituto Nacional de Salud, conforme a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INS.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, Brouwers S, Canavan MD, Ceconi C, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018. doi:10.1093/eurheartj/ehae178 PubMed PMID: 39210715.

2. Mills KT, Stefanescu A, He J. The global epidemiology of hypertension. Nat Rev Nephrol. 2020;16(4):223-37. doi:10.1038/s41581-019-0244-2 PubMed PMID: 32024986; PubMed Central PMCID: PMC7998524.

3. Zila-Velasque JP, Soriano-Moreno DR, Medina-Ramirez SA, Ccami-Bernal F, Castro-Diaz SD, Cortez-Soto AG, et al. Prevalence of hypertension in adults living at altitude in Latin America and the Caribbean: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2023;18(10):e0292111. doi:10.1371/journal.pone.0292111 PubMed PMID: 37824544; PubMed Central PMCID: PMC10569637.

4. Ruiz-Alejos A, Carrillo-Larco RM, Bernabé-Ortiz A. Prevalence and incidence of arterial hypertension in Peru: a systematic review and meta-analysis. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2021;38(4):521-9. doi:10.17843/rpmesp.2021.384.8502 PubMed PMID: 35385004.

5. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. Lancet. 2021;398(10304):957-80. doi:10.1016/S0140-6736(21)01330-1 PubMed PMID: 34450083; PubMed Central PMCID: PMC8446938.

6. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010;182(18):E839-842. doi:10.1503/cmaj.090449 PubMed PMID: 20603348; PubMed Central PMCID: PMC3001530.

7. Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2021 [citado 16 de septiembre de 2025]. (WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee). Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK573631/ PubMed PMID: 34495610.

8. Ministeria de Salud de Argentina. Argentina.gob.ar [Internet]. 2023 [citado 16 de septiembre de 2025]. Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial (HTA). Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/salud/habitos-saludables/guias-de-practica-clinica-y-documentos-de-apoyo

9. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ. 2017;358:j4008. doi:10.1136/bmj.j4008 PubMed PMID: 28935701; PubMed Central PMCID: PMC5833365.

10. Higgins JPT, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 18 de octubre de 2011;343:d5928. doi:10.1136/bmj.d5928 PubMed PMID: 22008217; PubMed Central PMCID: PMC3196245.

11. Ottawa Hospital Research Institute [Internet]. [citado 16 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp

12. Andrews JC, Schünemann HJ, Oxman AD, Pottie K, Meerpohl JJ, Coello PA, et al. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to recommendation-determinants of a recommendation's direction and strength. J Clin Epidemiol. julio de 2013;66(7):726-35. doi:10.1016/j.jclinepi.2013.02.003 PubMed PMID: 23570745.

13. Andrews J, Guyatt G, Oxman AD, Alderson P, Dahm P, Falck-Ytter Y, et al. GRADE guidelines: 14. Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. J Clin Epidemiol. julio de 2013;66(7):719-25. doi:10.1016/j.jclinepi.2012.03.013 PubMed PMID: 23312392.

14. Dewidar O, Lotfi T, Langendam MW, Parmelli E, Parkinson ZS, Solo K, et al. Good or best practice statements: proposal for the operationalisation and implementation of GRADE guidance. BMJ Evidence-Based Medicine. 2023;28(3):189-96. PubMed PMID: 35428694.

15. Guyatt G, Oxman AD, Sultan S, Brozek J, Glasziou P, Alonso-Coello P, et al. GRADE guidelines: 11. Making an overall rating of confidence in effect estimates for a single outcome and for all outcomes. J Clin Epidemiol. 2013;66(2):151-7. doi:10.1016/j.jclinepi.2012.01.006 PubMed PMID: 22542023.

16. Good or best practice statements: proposal for the operationalisation and implementation of GRADE guidance - PubMed [Internet]. [citado 16 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35428694/

17. Argentina.gob.ar [Internet]. 2023 [citado 14 de abril de 2025]. Guías de práctica clínica y documentos de apoyo. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/guias-de-practica-clinica-y-documentos-de-apoyo

18. Liu X, Zhang D, Liu Y, Sun X, Han C, Wang B, et al. Dose-Response Association Between Physical Activity and Incident Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies. Hypertension. 2017;69(5):813-20. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.08994 PubMed PMID: 28348016.

19. Adler AJ, Taylor F, Martin N, Gottlieb S, Taylor RS, Ebrahim S. Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2014(12):CD009217. doi:10.1002/14651858.CD009217.pub3 PubMed PMID: 25519688; PubMed Central PMCID: PMC6483405.

20. Hong Z, Wu T, Zhou S, Huang B, Wang J, Jin D, et al. Effects of anti-hypertensive treatment on major cardiovascular events in populations within prehypertensive levels: a systematic review and meta-analysis. J Hum Hypertens. 2018;32(2):94-104. doi:10.1038/s41371-017-0026-x PubMed PMID: 29317741.

21. Sundström J, Arima H, Jackson R, Turnbull F, Rahimi K, Chalmers J, et al. Effects of blood pressure reduction in mild hypertension: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2015;162(3):184-91. doi:10.7326/M14-0773 PubMed PMID: 25531552.

22. Brunström M, Carlberg B. Effect of antihypertensive treatment at different blood pressure levels in patients with diabetes mellitus: systematic review and meta-analyses. BMJ. 2016;352:i717. doi:10.1136/bmj.i717 PubMed PMID: 26920333; PubMed Central PMCID: PMC4770818.

23. Bi Y, Li M, Liu Y, Li T, Lu J, Duan P, et al. Intensive Blood-Pressure Control in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2025;392(12):1155-67. doi:10.1056/NEJMoa2412006 PubMed PMID: 39555827.

24. Ye N, Jardine MJ, Oshima M, Hockham C, Heerspink HJL, Agarwal R, et al. Blood Pressure Effects of Canagliflozin and Clinical Outcomes in Type 2 Diabetes and Chronic Kidney Disease: Insights From the CREDENCE Trial. Circulation. 2021;143(18):1735-49. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048740 PubMed PMID: 33554616.

25. Böhm M, Fitchett D, Ofstad AP, Brueckmann M, Kaspers S, George JT, et al. Heart failure and renal outcomes according to baseline and achieved blood pressure in patients with type 2 diabetes: results from EMPA-REG OUTCOME. J Hypertens. 2020;38(9):1829-40. doi:10.1097/HJH.0000000000002492 PubMed PMID: 32618884.

26. Brunström M, Carlberg B. Benefits and harms of lower blood pressure treatment targets: systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. BMJ Open. 2019;9(9):e026686. doi:10.1136/bmjopen-2018-026686 PubMed PMID: 31575567; PubMed Central PMCID: PMC6773352.

27. Lee LL, Mulvaney CA, Wong YKY, Chan ES, Watson MC, Lin HH. Walking for hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2021;2(2):CD008823. doi:10.1002/14651858.CD008823.pub2 PubMed PMID: 33630309; PubMed Central PMCID: PMC8128358.

28. Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jurgens G. Effects of low sodium diet versus high sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterol, and triglyceride. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(11):CD004022. doi:10.1002/14651858.CD004022.pub3 PubMed PMID: 22071811.

29. Yu D, Li JX, Cheng Y, Wang HD, Ma X di, Ding T, et al. Comparative efficacy of different antihypertensive drug classes for stroke prevention: A network meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2025;20(2):e0313309. doi:10.1371/journal.pone.0313309 PubMed PMID: 39982885; PubMed Central PMCID: PMC11845040.

30. Renin-Angiotensin-Aldosterone System Modulators in Adults with Hypertension: A Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials - PubMed [Internet]. [citado 26 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39312177/

31. Wei J, Galaviz KI, Kowalski AJ, Magee MJ, Haw JS, Narayan KV, et al. Comparison of Cardiovascular Events Among Users of Different Classes of Antihypertension Drugs: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA network open. 2020;3(2):e1921618. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.21618 PubMed PMID: 32083689.

32. Musini VM, Tejani AM, Bassett K, Puil L, Wright JM. Pharmacotherapy for hypertension in adults 60 years or older. Cochrane Database Syst Rev. 2019;6(6):CD000028. doi:10.1002/14651858.CD000028.pub3 PubMed PMID: 31167038; PubMed Central PMCID: PMC6550717.

33. Remonti LR, Dias S, Leitão CB, Kramer CK, Klassman LP, Welton NJ, et al. Classes of antihypertensive agents and mortality in hypertensive patients with type 2 diabetes-Network meta-analysis of randomized trials. J Diabetes Complications. 2016;30(6):1192-200. doi:10.1016/j.jdiacomp.2016.04.020 PubMed PMID: 27217022.

34. Wu HY, Huang JW, Lin HJ, Liao WC, Peng YS, Hung KY, et al. Comparative effectiveness of renin-angiotensin system blockers and other antihypertensive drugs in patients with diabetes: systematic review and bayesian network meta-analysis. BMJ. 24 de octubre de 2013;347:f6008. doi:10.1136/bmj.f6008 PubMed PMID: 24157497; PubMed Central PMCID: PMC3807847.

35. Zhang Y, He D, Zhang W, Xing Y, Guo Y, Wang F, et al. ACE Inhibitor Benefit to Kidney and Cardiovascular Outcomes for Patients with Non-Dialysis Chronic Kidney Disease Stages 3-5: A Network Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials. Drugs. junio de 2020;80(8):797-811. doi:10.1007/s40265-020-01290-3 PubMed PMID: 32333236; PubMed Central PMCID: PMC7242277.

36. Xie W, Zheng F, Evangelou E, Liu O, Yang Z, Chan Q, et al. Blood pressure-lowering drugs and secondary prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. J Hypertens. junio de 2018;36(6):1256-65. doi:10.1097/HJH.0000000000001720 PubMed PMID: 29543625.

37. Wang WT, You LK, Chiang CE, Sung SH, Chuang SY, Cheng HM, et al. Comparative Effectiveness of Blood Pressure-lowering Drugs in Patients who have Already Suffered From Stroke. Medicine (Baltimore). 2016;95(15):e3302. doi:10.1097/MD.0000000000003302 PubMed PMID: 27082571; PubMed Central PMCID: PMC4839815.

38. Garjón J, Saiz LC, Azparren A, Gaminde I, Ariz MJ, Erviti J. First-line combination therapy versus first-line monotherapy for primary hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2020;2(2):CD010316. doi:10.1002/14651858.CD010316.pub3 PubMed PMID: 32026465; PubMed Central PMCID: PMC7002970.

39. Thijs L, Richart T, de Leeuw PW, Kuznetsova T, Grodzicki T, Kawecka-Jaszcz K, et al. Morbidity and mortality on combination versus monotherapy: a posthoc analysis of the Systolic Hypertension in Europe trial. J Hypertens. 2010;28(4):865-74. doi:10.1097/HJH.0b013e32833627c9 PubMed PMID: 20051905.

40. Dahlöf B, Gosse P, Guéret P, Dubourg O, de Simone G, Schmieder R, et al. Perindopril/indapamide combination more effective than enalapril in reducing blood pressure and left ventricular mass: the

PICXEL study. J Hypertens. 2005;23(11):2063-70. doi:10.1097/01.hjh.0000187253.35245.dc PubMed PMID: 16208150.

41. Mogensen CE, Viberti G, Halimi S, Ritz E, Ruilope L, Jermendy G, et al. Effect of low-dose perindopril/indapamide on albuminuria in diabetes: preterax in albuminuria regression: PREMIER. Hypertension. 2003;41(5):1063-71. doi:10.1161/01.HYP.0000064943.51878.58 PubMed PMID: 12654706.

42. Hansson L, Lindholm LH, Ekbom T, Dahlöf B, Lanke J, Scherstén B, et al. Randomised trial of old and new antihypertensive drugs in elderly patients: cardiovascular mortality and morbidity the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 study. Lancet. 1999;354(9192):1751-6. doi:10.1016/s0140-6736(99)10327-1 PubMed PMID: 10577635.

43. Wu HY, Huang JW, Lin HJ, Liao WC, Peng YS, Hung KY, et al. Comparative effectiveness of renin-angiotensin system blockers and other antihypertensive drugs in patients with diabetes: systematic review and bayesian network meta-analysis. BMJ. 2013;347:f6008. doi:10.1136/bmj.f6008 PubMed PMID: 24157497; PubMed Central PMCID: PMC3807847.

44. Effects of amlodipine fosinopril combination on microalbuminuria in hypertensive type 2 diabetic patients - PubMed [Internet]. [citado 19 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12460699/

45. Verdecchia P, Staessen JA, Angeli F, de Simone G, Achilli A, Ganau A, et al. Usual versus tight control of systolic blood pressure in non-diabetic patients with hypertension (Cardio-Sis): an open-label randomised trial. Lancet. 2009;374(9689):525-33. doi:10.1016/S0140-6736(09)61340-4 PubMed PMID: 19683638.

46. Asayama K, Ohkubo T, Metoki H, Obara T, Inoue R, Kikuya M, et al. Cardiovascular outcomes in the first trial of antihypertensive therapy guided by self-measured home blood pressure. Hypertens Res. 2012;35(11):1102-10. doi:10.1038/hr.2012.125 PubMed PMID: 22895063.

47. SPRINT Research Group, Lewis CE, Fine LJ, Beddhu S, Cheung AK, Cushman WC, et al. Final Report of a Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. N Engl J Med. 2021;384(20):1921-30. doi:10.1056/NEJMoa1901281 PubMed PMID: 34010531; PubMed Central PMCID: PMC9907774.

48. Liu J, Li Y, Ge J, Yan X, Zhang H, Zheng X, et al. Lowering systolic blood pressure to less than 120 mm Hg versus less than 140 mm Hg in patients with high cardiovascular risk with and without diabetes or previous stroke: an open-label, blinded-outcome, randomised trial. Lancet. 2024;404(10449):245-55. doi:10.1016/S0140-6736(24)01028-6 PubMed PMID: 38945140.

49. JATOS Study Group. Principal results of the Japanese trial to assess optimal systolic blood pressure in elderly hypertensive patients (JATOS). Hypertens Res. 2008;31(12):2115-27. doi:10.1291/hypres.31.2115 PubMed PMID: 19139601.

50. Ogihara T, Saruta T, Matsuoka H, Shimamoto K, Fujita T, Shimada K, et al. valsartan in elderly isolated systolic hypertension (VALISH) study: rationale and design. Hypertens Res. 2004;27(9):657-61. doi:10.1291/hypres.27.657 PubMed PMID: 15750259.

51. Wei Y, Jin Z, Shen G, Zhao X, Yang W, Zhong Y, et al. Effects of intensive antihypertensive treatment on Chinese hypertensive patients older than 70 years. J Clin Hypertens (Greenwich). 2013;15(6):420-7. doi:10.1111/jch.12094 PubMed PMID: 23730991; PubMed Central PMCID: PMC8033887.

52. Zhang W, Zhang S, Deng Y, Wu S, Ren J, Sun G, et al. Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older Patients with Hypertension. N Engl J Med. 2021;385(14):1268-79. doi:10.1056/NEJMoa2111437 PubMed PMID: 34491661.

53. ACCORD Study Group, Cushman WC, Evans GW, Byington RP, Goff DC, Grimm RH, et al. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med. 2010;362(17):1575-85. doi:10.1056/NEJMoa1001286 PubMed PMID: 20228401; PubMed Central PMCID: PMC4123215.

54. SPS3 Study Group, Benavente OR, Coffey CS, Conwit R, Hart RG, McClure LA, et al. Blood-pressure targets in patients with recent lacunar stroke: the SPS3 randomised trial. Lancet. 10 de agosto de 2013;382(9891):507-15. doi:10.1016/S0140-6736(13)60852-1 PubMed PMID: 23726159; PubMed Central PMCID: PMC3979302.

55. Webb D, Dales J, Zaccardi F, Hill S, Moore C, Farooqi A, et al. Intensive versus standard multifactorial cardiovascular risk factor control in screen-detected type 2 diabetes: 5-year and longer-term modelled outcomes of the ADDITION-Leicester study. Diabetes Metab Res Rev. 2019;35(3):e3111. doi:10.1002/dmrr.3111 PubMed PMID: 30521699.

56. Klahr S, Levey AS, Beck GJ, Caggiula AW, Hunsicker L, Kusek JW, et al. The effects of dietary protein restriction and blood-pressure control on the progression of chronic renal disease. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. N Engl J Med. 1994;330(13):877-84. doi:10.1056/NEJM199403313301301 PubMed PMID: 8114857.

57. Wright JT, Bakris G, Greene T, Agodoa LY, Appel LJ, Charleston J, et al. Effect of blood pressure lowering and antihypertensive drug class on progression of hypertensive kidney disease: results from the AASK trial. JAMA. 2002;288(19):2421-31. doi:10.1001/jama.288.19.2421 PubMed PMID: 12435255.

58. Ruggenenti P, Perna A, Loriga G, Ganeva M, Ene-Iordache B, Turturro M, et al. Blood-pressure control for renoprotection in patients with non-diabetic chronic renal disease (REIN-2): multicentre, randomised controlled trial. Lancet. 2005;365(9463):939-46. doi:10.1016/S0140-6736(05)71082-5 PubMed PMID: 15766995.

59. Cheung AK, Rahman M, Reboussin DM, Craven TE, Greene T, Kimmel PL, et al. Effects of Intensive BP Control in CKD. J Am Soc Nephrol. 2017;28(9):2812-23. doi:10.1681/ASN.2017020148 PubMed PMID: 28642330; PubMed Central PMCID: PMC5576945.

60. Kitagawa K, Yamamoto Y, Arima H, Maeda T, Sunami N, Kanzawa T, et al. Effect of Standard vs Intensive Blood Pressure Control on the Risk of Recurrent Stroke: A Randomized Clinical Trial and Meta-analysis. JAMA Neurol. 1 de noviembre de 2019;76(11):1309-18. doi:10.1001/jamaneurol.2019.2167 PubMed PMID: 31355878; PubMed Central PMCID: PMC6664380.

61. Markus HS, Egle M, Croall ID, Sari H, Khan U, Hassan A, et al. PRESERVE: Randomized Trial of Intensive Versus Standard Blood Pressure Control in Small Vessel Disease. Stroke. agosto de 2021;52(8):2484-93. doi:10.1161/STROKEAHA.120.032054 PubMed PMID: 34044580.

62. Xu W, Goldberg SI, Shubina M, Turchin A. Optimal systolic blood pressure target, time to intensification, and time to follow-up in treatment of hypertension: population based retrospective cohort study. BMJ. 2015;350:h158. doi:10.1136/bmj.h158 PubMed PMID: 25655523; PubMed Central PMCID: PMC4353282.

63. Birtwhistle RV, Godwin MS, Delva MD, Casson RI, Lam M, MacDonald SE, et al. Randomised equivalence trial comparing three month and six month follow up of patients with hypertension by family practitioners. BMJ. 2004;328(7433):204. doi:10.1136/bmj.37967.374063.EE PubMed PMID: 14726370; PubMed Central PMCID: PMC318487.

VIII. GLOSARIO

- **Hipertensión arterial:** La hipertensión arterial es una elevación persistente de la presión sanguínea que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares,
- **Enfermedad cardiovascular:** Antecedente de infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica
- **Buena Práctica Clínica (BPC):** Recomendación basada en consenso de expertos cuando no hay evidencia científica directa. Sirve para orientar acciones clínicas relevantes, necesarias y beneficiosas.

- **Certeza de la evidencia:** Grado de confianza que se tiene en que los efectos estimados en los estudios se aproximen al efecto real de la intervención. Se clasifica como alta, moderada, baja o muy baja.
- **Desenlace**: Resultado o evento clínico importante para los pacientes, como mortalidad, efectos adversos, o calidad de vida. Se usa para evaluar la efectividad de una intervención.
- **Guía de Práctica Clínica (GPC):** Documento técnico basado en la mejor evidencia disponible que orienta a los profesionales de salud en la toma de decisiones clínicas sobre diagnóstico, tratamiento o prevención.
- **Grupo Elaborador de la Guía (GEG):** Equipo multidisciplinario de profesionales de salud responsable del desarrollo metodológico y técnico de una GPC.
- **Revisión sistemática (RS):** Resumen estructurado de estudios científicos, con métodos rigurosos de búsqueda, selección y análisis, usado como base para formular recomendaciones.